MALMÖ UNIVERSITET
FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE

BALANSEN MELLAN AUTONOMI OCH OMSORG

- en studie om LSS-personalens komplexa arbete

INDHIRA FREDLUND

Examensarbete i socialt arbete
61-90 hp
Socionomprogrammet
Januari 2026

Malmö universitet
Hälsa och samhälle
205 06 Malmö

THE BALANCE BETWEEN AUTONOMY AND DUTY OF CARE– A STUDY OF LSS-STAFF'S COMPLEX WORK

INDHIRA FREDLUND

Fredlund, I, The balance between autonomy and duty of care. A study of LSS-staff's complex work. Degree project in Social Work 15 credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of social work, 2026.

Abstracts
Despite the rights-based framework of the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), situations arise in which residents decline support and risk social isolation. This study aims to explore how staff in LSS group homes and supported housing perceive their responsibility and act in situations where residents refuse support, and how staff navigate the balance between self-determination and duty of care. The study also examines how relational, individual, and organisational factors influence preventive work against social isolation.

The study is based on a qualitative research design using semi-structured interviews with six professionals working in LSS services. The data were analysed using thematic analysis.

The findings show that residents' refusal of support is rarely understod as a clear expression of self-determination. Instead, refusals emerge as relational and situational, shaped by trust, previous experiences, mental health, cognitive difficulties, and organisational conditions. Relational and outreach-based work is identified as central to preventing social isolation, while variations in staff competence and interpretations of self-determination influence how risks are identified and managed. The results also highlight how a lack of clear routines and organisational structures may contribute to the normalisation of risk.
The study contributes with a deeper understanding of how self-determination within LSS is negotiated in everyday practice and underscores the importance of organisational support to enable active and preventive professional responsibility.

Keywords: attitudes, autism, community living, decline services, disengage, experience, group homes

FÖRORD

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Hanna Egard samt stödet i från min familj och vänner.
Malmö, mars 2026, Indhira Fredlund

Innehåll

1. INLEDNING 3
1.1 Begreppsdefinitioner 5
2. BAKGRUND 6
2.1 Historisk bakgrund – institutioner och relationer 6
2.2 Funktionshinders politiken idag 9
2.3 LSS och rättighetsbaserat stöd 9
2.4 Diagnosspecifika utmaningar 11
2.5 Relationella arbetsmetoder inom LSS 13
3. TIDIGARE FORSKNING 15
Självbestämmande, delaktighet och livskvalitet 15
Relationens betydelse i stöd 16
Orsaker till att boende tackar nej till insatser 17
Kompetens och professionellt ansvar i praktiken 19
Organisatoriska villkor- risk för social isolering 20
Sammanfattande reflektioner 20
4. TEORI 21
4.1 Omsorgsetik 22
4.2 Omsorgsrelationellt perspektiv 22
4.3 Gräsrotsbyråkrati 24
5. METOD 25
5.1.1 Tabell 26
Styrkor och begränsningar 29
6. RESULTAT OCH ANALYS 30
6.1 Relationellt och uppsökande arbete för att förebygga social isolering 30
6.2 Orsaker till att boende tackar nej till insatser 32
6.3 Attityder och värderingar kring *självbestämmande samt risk för social isolering* 35
6.4 Metoder och rutiner för att förebygga social isolering 39
7. Metoddiskussion 43
8. DISKUSSION 44
9. Slutsats 45
Referenser 46
Tabell 1. Litteraturöversikt Tidigare forskning 50
BILAGA 1 Informationsbrev 51
BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 53

1. INLEDNING

Rättigheter, självbestämmande och LSS

En individs funktionsnedsättning ska inte avgöra hur mycket inflytande personen har över sitt eget liv, detta betonas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen betonas det att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande jämlika levnadsvilkor (United Nations, 2006; Funktionsrätt, 2021). Ett övergripande mål är att motverka diskriminering och att stärka självbestämmande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. (Lindberg & Grönvik, 2012).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade infördes år 1994. Lagen har som mål att personer som omfattas av LSS ska kunna leva ett liv så likt andras som möjligt. När lagen trädde i kraft fick kommunerna ett tydligt ansvar för att säkerställa att stödinsatser genomförs i enlighet med lagens intentioner. Detta innebär att stödet ska bidra till självbestämmande, delaktighet och möjlighet att påverka den egna livssituationen (SFS 1993:387; Bengtsson, 2008).

Självbestämmande och social isolering

Forskning att självbestämmande inte enbart kan förstås som en formell rättighet. Det formas även i relationer och i det stöd som ges i vardagen. Hur stöd erbjuds och hur relationen mellan personal och boende ser ut har därför stor betydelse för hur självbestämmande kan komma till uttryck i praktiken (Schalock & Verdugo, 2019).

Inom LSS-verksamheter förekommer situationer där boende tackar nej till stöd eller drar sig undan från personalen. Forskning visar att detta kan innebära en ökad risk för att både psykisk och social ohälsa försämras (Socialstyrelsen, 2013). Vidare att ett nej till stöd kan ibland förstås som ett uttryck för självbestämmande. Samtidigt kan det också vara ett uttryck för andra faktorer (Carlén, Palmqvist och Puaca, 2023). Det kan handla om svårigheter i socialt samspel, bristande tillit till personalen eller tidigare negativa erfarenheter av stödinsatser. Således när boende tackar nej till stöd behöver tolkas med försiktighet och förstås i sitt sammanhang (Topor, 2001).

Missförhållanden och risk för missförhållanden

Personal inom LSS-verksamheter har som ansvar att uppmärksamma både missförhållanden och risker för missförhållanden. Detta regleras genom dokumentation och avvikelsehantering som kan efter utredning leda till Lex Sarah. Skyldigheten innebär att personal ska agera när det finns tecken på att en boendes hälsa, trygghet eller livskvalitet riskerar att påverkas negativt (Socialstyrelsen, 2013). Dock visar forskning att personalens möjligheter till att hantera risker påverkas av organisatoriska förutsättningar såsom personalomsättning, tidsbrist och otydliga rutiner vilket kan försvåra det relationsskapande arbetet (Lipsky, 2010; Lindvig med flera, 2021).

Problemformulering

Social isolering och avståndstagande från personal utgör en särskild utmaning inom LSS-boenden, särskilt i verksamheter där boende har autism och/eller psykossjukdom. Dessa funktionsnedsättningar kan innebära svårigheter i kommunikation och socialt samspel. Vidare kan det påverka individens möjligheter att skapa och upprätthålla relationer, vilket i sin tur kan påverka hur stöd uppfattas och tas emot (Gillberg, u.å.; Lo med flera, 2025).

När en boende tackar nej till stöd kan detta vid första tolkning förstås som ett uttryck för självbestämmande, en central princip inom både FN konventionen och LSS. Samtidigt visar forskning att självbestämmande inte enbart kan förstås som en juridisk rättighet, utan formas i relationer och i det stöd som ges i praktiken. Ett nej till stöd kan därför även spegla bristande tillit, tidigare negativa erfarenheter eller relationella faktorer snarare än ett informerat val (Schalock & Verdugo, 2019; Topor, 2001).

I dessa situationer ställs personal inom LSS inför komplexa avvägningar mellan att respektera den enskildes självbestämmande och att ta ansvar för omsorg, trygghet och riskbedömning. Social isolering kan innebära att behov inte uppmärksammas, vilket kan leda till uteblivet stöd och risk för missförhållanden enligt Lex Sarah (Socialstyrelsen, 2013). Samtidigt påverkas personalens möjligheter att arbeta förebyggande av organisatoriska förutsättningar såsom personalomsättning, tidsbrist och otydliga rutiner, vilket kan begränsa handlingsutrymmet i praktiken (Lipsky, 2010; Lindvig med flera, 2021).

Trots att tidigare forskning belyser självbestämmande, relationers betydelse och organisatoriska villkor var för sig, finns begränsad kunskap om hur dessa faktorer samspelar i personalens praktiska resonemang när boende tackar nej till stöd och samtidigt riskerar social isolering. Särskilt saknas kunskap om hur personal uppfattar sitt ansvar och navigerar mellan etiska, relationella och organisatoriska krav i dessa situationer inom LSS-verksamheter.

Sammantaget finns ett behov av fördjupad kunskap om hur personal inom LSS uppfattar sitt ansvar och agerar i situationer där boende tackar nej till stöd och riskerar social isolering, samt hur organisatoriska förutsättningar påverkar detta arbete.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal inom LSS-boenden upplever sitt ansvar och agerar vid risk för missförhållanden, samt hur de samtidigt förhåller sig till den enskildes rätt till självbestämmande när risk föreligger. Vidare syftar studien till att belysa vilka arbetssätt och rutiner som används för att förebygga och hantera situationer där risken för missförhållanden ökar, exempelvis när en boende tackar nej till insatser och socialt isolerar sig från personalen.

Frågeställningar

- Vad uppfattar personal inom LSS kan ligga bakom att boende tackar nej till insatser och riskerar att socialt isolera sig?
- Vilka attityder och värderingar uttrycker personalen i relation till att boende tackar nej till stödinsatser?
- Vilka arbetssätt beskriver personalen att de tillämpar för att förebygga social isolering, och hur påverkas dessa av organisatoriska förutsättningar?

1.1 Begreppsdefinitioner

I avsnittet nedan följer förklaring på olika begrepp som är relevanta för att kunna tyda studien.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Begreppet funktionsnedsättning avser en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga, medan funktionshinder beskriver hur funktionsnedsättningen samspelar med omgivningen. Ett funktionshinder uppstår när bristande tillgänglighet eller avsaknad av anpassningar begränsar individens möjlighet till autonomi och delaktighet (Lindberg & Grönvik, 2012).

Särskilt boende – LSS-boende

En bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS avser ett boende för vuxna personer med omfattande funktionsnedsättningar, där stödet ska vara individuellt anpassat och utformas i enlighet med lagens intentioner om självbestämmande och goda levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2024).

Boende

I denna studie används begreppet *boende* i stället för *brukare*. Enligt Socialstyrelsens terminologi avser begreppet brukare personer som tar del av stödinsatser enligt LSS och som bor i gruppbostad eller servicebostad (Socialstyrelsen, 2026).

Valet att använda begreppet boende grundar sig i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Författaren bedömer att begreppet brukare inte är salutogent. Genom att använda benämningen boende betonas individen i första hand som person och hyresgäst i sin bostad. Stödbehovet ses som sekundärt.

Yrkesbeteckningar

I studien används begreppet *personal* som ett samlingsnamn för stödassistenter, stödpedagoger och chef för sektionschefer.

Självbestämmande- Omsorg & Relationellt perspektiv

I studien förstås *självbestämmande* som individens rätt och faktiska möjlighet till att fatta beslut om sitt eget liv och om sin vardag enligt LSS och ett rättighetsbaserat perspektiv (SFS 1993:387; United Nations, 2006).

Med *omsorg* menas med personalens professionella ansvar att förebygga risk och ohälsa även i situationer där det kan påverka personens självbestämmande (Tronto, 1994).

Ett *relationellt perspektiv* innebär att individers handlingar förstås utifrån deras relationer livssituation och tidigare erfarenheter. Vidare betyder det att det är inte endast från egna val (Isenberg & Stenberg, 2013).

2. BAKGRUND

Bakgrunden ger en översikt över den historiska och politiska utveckling som har format dagens LSS-boenden i Sverige. Historiskt har personer med funktionsnedsättningar levt under mycket svåra villkor. Många har varit utsatta för diskriminering och social exkludering. Under lång tid saknade dessa individer möjlighet till självbestämmande och delaktighet i samhället (Socialstyrelsen, 2018).

Utvecklingen sträcker sig från en period med stora institutioner och mycket begränsat inflytande, till nya reformer som i stället betonade medborgarskap, rättigheter och individanpassat stöd (Lindberg med flera, 2003). För att kunna förstå de utmaningar som personal möter i dagens LSS-boenden är det därför nödvändigt att följa denna utveckling i kronologisk ordning. Historiska synsätt och tidigare arbetssätt påverkar fortfarande hur ansvar förstås i dagens LSS-boenden. De påverkar också hur relationer mellan personal och boende formas. Synen på självbestämmande präglas i många fall av dessa äldre sätt att tänka trots att det inte är medvetet samt även om lagstiftning och policy har förändrats över tid.

2.1 Historisk bakgrund – institutioner och relationer

Under större delen av 1900-talet bedrevs omsorg och psykiatrisk vård i Sverige huvudsakligen på stora institutioner och mentalsjukhus. Personer med olika former av funktionsnedsättningar levde ofta under mycket svåra förhållanden. Social isolering var vanligt förekommande. Många hade mycket begränsat inflytande över sina liv och befann sig i en situation av nästan total maktlöshet (Socialstyrelsen, 2018).

Lindberg och Grönvik (2012) beskriver hur två typer av institutioner dominerade under denna period. Den ena typen var sinnesslöanstalter för personer med psykiska funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom. Den andra typen var vanföreanstalter för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Sverige hade vid denna tid ett av västvärldens största institutionssystem i förhållande till befolkningens storlek.

Institutionerna präglades av en tydlig hierarkisk struktur. Personalens uppgift var i första hand att upprätthålla ordning och rutiner. Relationsskapande arbete och individens självbestämmande hade låg prioritet. Detta institutionella synsätt har fortsatt att påverka omsorgen även efter att institutionerna avvecklats. Spår av dessa arbetssätt kan fortfarande märkas inom dagens LSS-boenden (Askheim, Bengtsson, & Bjelke, 2014)

Normaliseringsprincipen

Lindberg och Grönvik (2012) betonar att under 1950- och 1960-talen växte en allt starkare kritik fram mot institutionsvården. Som ett alternativ utvecklades normaliseringsprincipen. Principen betonade att personer med funktionsnedsättningar skulle ges möjlighet att leva liv som i så stor utsträckning som möjligt liknade andras. Detta innebar goda levnadsvillkor och tillgång till vardagliga livsmönster samt att personer med funktionsnedsättning hade rätt till bostad, arbete och fritid. Således skulle de inte längre samlas på institutioner utan integreras i samhället. Principen blev ett viktigt steg i att se personer med funktionsnedsättning som medborgare med rättigheter. Detta lade grunden för senare reformer som betonade delaktighet och självbestämmande (Lindberg & Grönvik, 2012).

1990-talets handikapp- samt psykiatrireformen

Under 1990-talet genomfördes flera omfattande reformer inom funktionshinder- och psykiatriområdet. Ejneborn Looi och Gabrielsson (2023) beskriver hur psykiatrireformen syftade till att ersätta institutionsvården med stöd i samhället. I utredningen inför reformen beskrevs hur mentalsjukhusen riskerade att skapa isolering och passivitet. Det fanns även bristande respekt för individens autonomi och resurser (SOU 1992:73).

Reformen innebar att kommunerna fick ansvar för boende, sysselsättning och socialt stöd. Regionerna behöll ansvaret för den psykiatriska vården (Markström, 2003). I riksdagsmotion 1998/99:So349 betonades det att många personer med psykiska funktionsnedsättningar levt under villkor som kraftigt begränsat både självbestämmande och delaktighet. Reformen krävde därför långsiktigt ansvarstagande och samordning för att undvika att människor återigen hamnade i utsatthet (Bengtsson, 2008).

Bengtsson (2008) berättar att med handikappreformen innebar det samtidigt en tydlig förskjutning från ett medicinskt synsätt till ett medborgarskapsperspektiv. När LSS-lagen antogs 1993 var syftet att personer med funktionsnedsättning skulle ges möjlighet att leva som andra. Stödet skulle vara individanpassat och bidra till ökad livskvalitet, delaktighet och självbestämmande (Bengtsson, 2008). Kommunerna fick ansvar för att säkerställa att insatserna genomfördes korrekt och i dialog med individen.

Från patient till medborgare

Den svenska funktionshinderpolitiken har under senare decennier genomgått en tydlig förändring. Fokus har successivt förflyttats från ett medicinskt synsätt, där personer med funktionsnedsättning främst betraktades som patienter, till ett

rättighets- och medborgarskapsperspektiv. I detta perspektiv betonas individens rätt till självbestämmande, delaktighet och jämlika levnadsvillkor (Prop. 1999/2000:79; Lindberg & Grönvik, 2012).

I handlingsplanen Från patient till medborgare tydliggjorde regeringen att funktionshinderpolitiken ska utgå från dessa principer och att samhället har ett ansvar att undanröja hinder som begränsar individers möjligheter att leva som andra (Regeringen, 2000). Myndigheten för delaktighet har senare haft i uppdrag att följa upp och stödja genomförandet av funktionshinderpolitiken samt att bidra med kunskap om hur delaktighet och jämlika levnadsvillkor kan stärkas i praktiken (Myndigheten för delaktighet, 2021).

Samtidigt visar både forskning och myndighetsrapporter att många hinder kvarstår i praktiken. Detta innebär att personer med funktionsnedsättning fortfarande riskerar att leva under ojämlika villkor och ha begränsat inflytande över sin egen livssituation, trots de rättighetsbaserade ambitionerna (Lindberg & Grönvik, 2012; Socialstyrelsen, 2018; Regeringen, 2021).

Tillkomsten av CRPD

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, antogs år 2006. Konventionen förstärkte det rättighetsbaserade synsättet ytterligare. Den tydliggör att personer med funktionsnedsättning har samma mänskliga rättigheter som alla andra. Stöd ska utformas så att autonomi, delaktighet och skydd mot försummelse säkerställs (United Nations, 2006). Funktionsrätt Sverige (2021) betonar att ett samhälle för alla kräver att varje människas värde respekteras. Personer med funktionsnedsättning ska ges makt och delaktighet på lika villkor. CRPD och LSS-lagen uttrycker därmed ett gemensamt synsätt där stöd ska utformas i dialog med individen och anpassas efter behov, förmågor och önskemål.

Självbestämmande, isolering och personalens dubbla ansvar

De historiska och politiska förändringarna är viktiga för att förstå dagens LSS-boenden och personalens arbete. Kunskap om denna utveckling har betydelse i mötet mellan personal och boende. Tidigare synsätt påverkar fortfarande hur ansvar, relationer och självbestämmande förstås i praktiken (Lindberg & Grönvik, 2012; Egard med flera, 2016).

Individens möjlighet att kommunicera behov och skapa tillit påverkas av både funktionsnedsättning och tidigare erfarenheter. Social isolering kan därför inte enbart förstås som ett individuellt val utan behöver ses i relation till det stöd som erbjuds (Socialstyrelsen, 2013).

CRPD och LSS-lagen innebär att personal inom LSS har ett dubbelt ansvar. De ska respektera den boendes självbestämmande och samtidigt agera när det finns risk att behov inte tillgodoses (United Nations, 2006; SFS 1993:387).

2.2 Funktionshinders politiken idag

Sveriges nutida funktionshinderpolitik bygger på ett rättighetsbaserat synsätt . Målet är att personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika levnadsvillkor och möjlighet till delaktighet. Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet ska även vara tydligt närvarande i detta arbete (Regeringen, 2021; Myndigheten för delaktighet, 2021).

Politiken utgår från det nationella målet och regeringen betonar behovet av systematisk uppföljning. Syftet är att tydligare se vilka insatser som fungerar och vilka som behöver stärkas. Flera myndigheter har därför fått i uppdrag att följa upp politiken under perioden 2021-2031. Myndigheten för delaktighet har ett särskilt ansvar för att stödja detta arbete (Regeringen, 2021; Myndigheten för delaktighet, 2022).

Funktionshinderpolitiken påverkas även av sektorsansvaret. Det innebär att varje samhällssektor ansvarar för att funktionshinderperspektivet integreras i den ordinarie verksamheten. Detta ska ske inom befintliga budgetramar. Sammantaget kombinerar politiken ett tydligt rättighetsperspektiv med ökade krav på uppföljning och genomförande (Socialstyrelsen, 2024).

2.3 LSS och rättighetsbaserat stöd

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är det regelverk som styr stödinsatser inom funktionshinderområdet. Enligt LSS 5 § ska verksamheten främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Detta innebär att den enskilde ska ges faktiska möjligheter att påverka sin vardag och de stödinsatser som ges (SFS 1993:387).

I LSS 6 § anges att verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Individens vilja och upplevelse ska därför vara vägledande vid planering och genomförande av stöd. Socialstyrelsen betonar att detta förutsätter ett arbetssätt där stöd ges i dialog med den enskilde och anpassas efter individuella behov (Socialstyrelsen, 2025).

Vidare anger LSS 7 § att insatser ska vara individuellt anpassade och utformas utifrån den enskildes livssituation. Detta kräver ett personcentrerat arbetssätt där stödinsatser formas tillsammans med den boende. Sammanfattningsvis uttrycker dessa paragrafer ett rättighetsbaserat synsätt där självbestämmande, delaktighet och individanpassning utgör grundläggande principer för allt stöd inom LSS (SFS 1993:387; Socialstyrelsen, 2025).

Målgrupp- Personkretsar

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, riktar sig till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningarna ska innebära stora svårigheter i den dagliga livsföringen (SFS 1993:387). Endast personer som tillhör någon av lagens tre personkretsar omfattas av LSS. Personkretsbedömningen är därför central i både rättighetsprövning och det praktiska stödarbetet.

Den första personkretsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Den andra personkretsen gäller personer som i vuxen ålder har fått en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning till följd av hjärnskada. Den tredje personkretsen omfattar personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningarna ska påverka vardagen i hög grad (SFS 1993:387).

I förarbetena till lagen betonas att även långvariga psykiska funktionsnedsättningar kan omfattas av personkretsen. Avgörande är att funktionsnedsättningen är varaktig och medför ett omfattande behov av stöd i vardagen (Socialdepartementet, 1993).

Sammanfattningsvis riktar sig LSS till en tydligt avgränsad grupp personer med omfattande stödbehov. Diagnoser kan vara vägledande i bedömningen. Det är dock konsekvenserna av funktionsnedsättningen och behovet av stöd som avgör rätten till insatser enligt lagen, inte diagnosen i sig (SFS 1993:387; Socialdepartementet, 1993).

Särskilda boenden och IBIC

Inom LSS finns möjlighet att få ett boende som är anpassat för personer som behöver mer stöd i vardagen än vad som kan ges i ett eget hem. Det gäller insatserna bostad med särskild service för vuxna samt bostad med särskild service för barn och ungdomar. Dessa insatser regleras i 9 §§ 8-9 LSS (Socialstyrelsen, 2025). För att beviljas ett sådant boende behöver personen tillhöra någon av lagens tre personkretsar enligt 1 § LSS. Boendet ska ge trygghet och kontinuitet samt stöd som utformas efter individens behov. Målet är att skapa goda levnadsvillkor och stärka självbestämmande och delaktighet enligt 5 § LSS (Socialstyrelsen, 2025).

Kommunen ansvarar för tillgången till boendena och för att stödet fungerar i praktiken enligt 15 § LSS. Om en ansökan avslås kan beslutet överklagas till domstol enligt 21 § LSS. Socialstyrelsen beskriver att syftet med boendeinsatser är att ge stöd som stärker individens självständighet samt trygghet och delaktighet i vardagen (Socialstyrelsen, 2025).

Socialstyrelsen (2025) betonar att arbetet med boendeinsatser utgår ofta från IBIC. IBIC bygger på Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). ICF används för att beskriva hur en person fungerar i vardagen utifrån fysiska, psykiska och sociala aspekter. Genom att använda IBIC får handläggare och utförare ett gemensamt språk. Det gör det lättare att dokumentera individens resurser, behov och mål på ett strukturerat sätt (Socialstyrelsen, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen, 2018).

När IBIC används i dokumentation skapas ett gemensamt arbetssätt i verksamheten. Det underlättar för personal att förstå och beskriva individens situation. En tydlig struktur minskar risken för missförstånd och gör informationsöverföringen mer sammanhållen. Systematiska uppföljningar gör det

också möjligt att se hur stödet fungerar över tid och att identifiera behov av utveckling i verksamheten (Socialstyrelsen, 2025).

Lex Sarah-Missförhållanden

När det gäller risk för missförhållanden är Lex Sarah-bestämmelserna de viktigaste. Enligt 24-26 §§ LSS med hänvisning till 14 kap. 3 § SoL är personal skyldig att rapportera både missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten. Ett missförhållande kan vara en handling eller en underlåtenhet som innebär eller riskerar att innebära skada, försummelse eller bristande omsorg för den enskilde (Socialstyrelsen, 2013). Detta innebär att personalens ansvar inte enbart handlar om att respektera självbestämmande. De ska också agera när individens hälsa, trygghet eller livskvalitet riskerar att påverkas negativt (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsens föreskrifter betonar att verksamheter ska ha tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera risker. Personalen ska veta hur situationer ska hanteras när en boende tackar nej till stöd. Risker ska också dokumenteras och följas upp. Det är verksamhetens ledning som ansvarar för att dessa förutsättningar finns för att ge ett tryggt och säkert stöd (SOSFS 2011:9; Socialstyrelsen, 2013)

Social isolering

Socialstyrelsen beskriver social isolering som ett återkommande problem för personer med funktionsnedsättning. Risken är särskilt stor när stödinsatser ställs in eller förändras. Många personer har redan från början begränsade sociala kontakter. Isoleringen kan därför fördjupas när daglig verksamhet inte genomförs som planerat eller när tillgången till gemensamma utrymmen i boenden minskar (Socialstyrelsen, 2021).

När kontinuiteten i stöd och sociala sammanhang bryts minskar individens möjligheter till delaktighet. Detta kan i sin tur påverka både funktionsförmåga och välbefinnande negativt. Socialstyrelsen betonar att minskad tillgång till stöd ofta leder till försämrat mående. Det visar hur nära kopplad social isolering är till psykisk hälsa och vardagsfungerande (Socialstyrelsen, 2021).

Sammanfattningsvis kan social isolering förstås som ett strukturellt problem då hur stödinsatser organiseras och genomförs har stor betydelse och när stöd uteblir eller begränsas riskerar isoleringen att fördjupas. Detta står i direkt motsats till LSS-lagens intentioner om delaktighet, om självbestämmande och goda levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2025).

2.4 Diagnosspecifika utmaningar

I detta avsnitt beskrivs diagnoser som är relevanta för studien. Fokus ligger på hur dessa kan yttra sig i vardagen och vilka utmaningar de kan innebära i relation till stöd och socialt samspel.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som omfattar både lindrigare psykiska besvär och mer omfattande psykiatriska tillstånd. Dessa tillstånd kan påverka individens känslor, kognition och sociala funktion (American Psychiatric Association, 2015). Psykisk ohälsa kan också förekomma tillsammans med funktionsnedsättningar. Detta kan leda till ett ökat lidande och ytterligare nedsatt funktionsförmåga i vardagen (American Psychiatric Association, 2015).

Socialstyrelsen betonar att psykisk ohälsa ofta kan innebära svårigheter i sociala relationer. Hur stor påverkan den psykiska ohälsan har varierar mellan individer. För vissa kan påverkan vara begränsad medan den för andra kan vara omfattande och påverka vardagsfungerandet i hög grad (Socialstyrelsen, 2024).

Autism

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av svårigheter inom social kommunikation och social interaktion. Begränsade och repetitiva beteenden är också vanliga. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar, till exempel intellektuell funktionsnedsättning (American Psychiatric Association, 2015).

Personer med autism kan ha svårigheter med social ömsesidighet. Det kan handla om att initiera kontakt eller att svara på andras försök till kontakt. Detta kan påverka möjligheten att skapa och upprätthålla relationer (Gillberg, 2018). Avvikelser i icke-verbal kommunikation, såsom ögonkontakt, gester och ansiktsuttryck, är också vanligt förekommande. Detta kan leda till missförstånd i sociala situationer (American Psychiatric Association, 2015).

Gillberg (2028) beskriver även att personer med autism ofta har ett stort behov av tydlighet och struktur. Förändringar och oförutsägbarhet kan upplevas som påfrestande. Sensorisk över- eller underkänslighet förekommer också. Miljöer som är högljudda eller socialt krävande kan därför bli överväldigande. I sådana situationer kan individens möjlighet att ta emot stöd påverkas, särskilt om bemötande och kommunikation inte är anpassade efter individens behov (Gillberg, 2018). Theory of Mind används inom autismforskningen för att beskriva förmågan att förstå att andra människor har egna tankar, känslor och intentioner. Dessa kan skilja sig från de egna (Gillberg, 2018). Förmågan är viktig för socialt samspel och för att tolka andras beteenden i vardagen.

Enligt American Psychiatric Association ska symtomen ha funnits sedan tidig utveckling, även om de ibland blir tydligare först senare i livet. Symtomen ska innebära betydande svårigheter i socialt samspel eller vardagsfungerande. Autism kan förekomma i olika former och svårighetsgrader. Den kan finnas både med och utan intellektuell funktionsnedsättning, samt med eller utan nedsatt språklig förmåga (Gillberg, 2018; American Psychiatric Association, 2015).

Psykossjukdom

Friberg med flera (2019) beskriver psykos som ett samlingsnamn för olika symtom som uppstår till följd av en bakomliggande psykiatrisk sjukdom. Psykos

är alltså inte en sjukdom i sig. Symtomen kan utvecklas snabbt eller mer gradvis och kännetecknas av att individens verklighetsuppfattning förändras (Friberg, Geuken & Wächter, 2019).

Två centrala psykotiska symtom är vanföreställningar och hallucinationer. Vanföreställningar innebär tankar och föreställningar som inte delas av andra och som inte kan påverkas av logiska förklaringar. Hallucinationer är sinnesupplevelser utan yttre stimuli och kan förekomma inom alla sinnen, till exempel hörsel, syn eller känsel (Friberg, Geuken & Wächter, 2019). Det kan innebära att individen upplever sig förföljd eller hotad. Vidare kan det också handla om föreställningar om att bli skadad eller kontrollerad. Vardagliga föremål som elektronisk utrustning, kan upplevas ha en särskild och hotfull betydelse. Hörselhallucinationer är ett annat vanligt symtom. Dessa kan vara neutrala men också kritiska eller uppfordrande. I vissa fall förekommer röster som ger direkta uppmaningar, till exempel att skada sig själv eller andra (Friberg, Geuken & Wächter, 2019).

DSM-5 beskriver att psykotiska symtom påverkar individens förmåga att tolka omvärlden och förstå sociala situationer. Vanföreställningar, hallucinationer och desorganiserat tänkande kan leda till svårigheter i socialt samspel. Individen kan misstolka andras intentioner eller uppfatta neutrala situationer som hotfulla. Detta kan leda till att personen drar sig undan kontakt och får svårt att upprätthålla relationer, både med närstående och med personal (American Psychiatric Association, 2015).

I LSS-boenden där personal möter boende i vardagliga situationer blir förståelsen för psykosens påverkan särskilt viktig. När individens verklighetsuppfattning skiljer sig från omgivningens kan tillit, trygghet och kommunikation påverkas. Detta ställer krav på ett lugnt, lyhört och anpassat bemötande från personalens sida (Socialstyrelsen, 2025)

2.5 Relationella arbetsmetoder inom LSS

Social isolering kan försvåra både delaktighet och möjligheten att uppmärksamma behov i tid. Därför blir personalens sätt att arbeta och bygga relationer avgörande inom LSS. Relationellt arbete som präglas av lyhördhet och kontinuitet är en viktig förutsättning för att motverka isolering och främja återhämtning (Topor, 2001; 2016).

Topor (2001;2016) betonar att arbete inom LSS och socialpsykiatri vilar på ett rättighetsbaserat synsätt där relationen mellan personal och boende är central. Ejneborn Looi och Gabrielsson (2023) berättar att återhämtning handlar främst om sociala och relationella processer där individen återtar kontroll och finner mening i vardagen. Det är den boende som återhämtar sig, medan personalens roll är att arbeta personcentrerat och skapa stödjande förutsättningar.

Relationens kvalitet påverkar om en boende tar emot stöd eller tackar nej. Forskning visar att personalens vardagliga handlingar, deras lyhördhet och engagemang har stor betydelse (Belin, 2013). När relationen präglas av tillit och kontinuitet ökar möjligheten att individen vågar ta emot stöd. Om relationen

upplevs som kontrollerande eller otydlig kan det i stället leda till tillbakadragande och ökad isolering (Brunt & Rask, 2018; Lindvig med flera, 2021).

Socialstyrelsen lyfter att bristande delaktighet och självbestämmande utgör en riskfaktor för missförhållanden. Detta gäller särskilt i situationer där personer tackar nej till stöd trots att deras livssituation innebär tydliga risker (Socialstyrelsen, 2011; 2013; 2020).

Personcentrerat arbete

Topor betonar att ett personcentrerat arbetssätt innebär att stöd utformas utifrån individens perspektiv och erfarenheter (Topor, 2005). Zoffmann med flera (2016) beskriver personcentrering som ett arbetssätt där personalen arbetar lyhört och anpassar kommunikationen efter individen. Arbetet bygger också på gemensam målformulering mellan personal och individ (Zoffmann med flera, 2016).

Inom LSS är personcentrering inte enbart en metod. Det är även en lagstadgad princip som utgår från självbestämmande, integritet och individuellt anpassat stöd enligt LSS 5-7 §§ (Socialstyrelsen, 2011).

Återhämtningsinriktat arbete

Återhämtningsinriktat arbete är centralt inom både LSS och socialpsykiatri. Forskning visar att återhämtning främjas av relationer som präglas av hopp, respekt och delaktighet (Topor, 2001; 2016).

Återhämtning kan förstås som en process där individen återtar kontroll över sitt liv och skapar mening i vardagen (Ejneborn Looi & Gabrielsson, 2023). I praktiken innebär detta att personalen arbetar för att stärka individens egenmakt och känsla av sammanhang genom ett stöd som utgår från den boendes behov och förutsättningar (Ejneborn Looi & Gabrielsson, 2023).

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal, MI, används inom LSS för att stärka delaktighet och minska motstånd i vardagliga situationer. Socialstyrelsen betonar att samtalsmetoder som bygger på lyhördhet och respekt är centrala för att främja självbestämmande. Det är också viktigt att individens vilja utforskas genom dialog och anpassad kommunikation (Socialstyrelsen, 2011; 2013; 2020).

MI kan därför förstås som ett arbetssätt som ligger i linje med Socialstyrelsens rekommendationer om att stödja individens autonomi. Hall och Christensen beskriver MI som ett förhållningssätt som bidrar till psykologisk trygghet och stärker relationen mellan personal och individ (Hall & Christensen, 2025).

Utöver återhämtningsinriktat, personcentrerat arbete och MI så förekommer det flera strukturerade arbetssätt inom funktionshinderområdet, exempelvis Active Support, Positive Behavior Support (PBS) och intensiv interaktion, som på olika sätt syftar till att stärka delaktighet, anpassa stöd och underlätta kommunikation (Mansell & BeadleBrown, 2012; Strydom med flera, 2020; Angberg med flera, 2023; Nind & Hewett, 1994). Empowerment kan samtidigt förstås som en princip

som betonar individens inflytande och personalens roll att stödja självbestämmande i praktiken (Verdugo & Schalock, 2019).

3. TIDIGARE FORSKNING

I detta avsnitt presenteras forskning som är relevant för att förstå stödet i LSS-boenden och de utmaningar personal möter i vardagen. Avsnittet är tematiskt uppbyggt. Inledningsvis behandlas forskning om självbestämmande, delaktighet och livskvalitet, centrala områden i LSS-lagstiftningen och det dagliga stödet. Därefter följer studier om relationens betydelse och hur tillit och kontakt påverkar möjligheten att ge stöd. Vidare presenteras forskning om orsaker till att boende tackar nej till insatser, vilket bidrar till en fördjupad förståelse av tillbakadragande. Avslutningsvis redovisas forskning om kompetens och professionellt ansvar, med fokus på två utvärderade arbetssätt: Positive Behavior Support (PBS) och Active Support. Tillsammans ger dessa forskningsområden en samlad bild av det komplexa stöd som ges inom LSS-boenden.

Litteratursökningar

Litteraturen identifierades främst via Malmö universitets biblioteks databassökning i SwePub, Google Scholar, Social Abstracts och PsycINFO. Därutöver tillkom litteratur som rekommenderats av handledare samt relevant litteratur från tidigare utbildningar.

En utmaning var att hitta aktuell svensk forskning, då mycket av den tillgängliga litteraturen var äldre än tio år och därför bedömdes som mindre relevant för studien. Detta gjorde sökprocessen mer tidskrävande.

Sökord som användes inkluderade bland annat autism, IF, psykossjukdom, LSS, självbestämmande, social isolering, relation och arbetssätt. Även engelska sökord användes, såsom decline services, refusal of support, staff, supported housing, group homes och community living. Kombinationer av dessa sökord möjliggjorde identifiering av både nationell och internationell forskning relevant för studiens syfte.

Självbestämmande, delaktighet och livskvalitet

Forskning visar att självbestämmande och delaktighet har ett nära samband med livskvalitet hos personer med funktionsnedsättning i boendeformer. Möjligheten att påverka sin vardag och vara delaktig i beslut som rör det egna livet bidrar till ökat välbefinnande, samtidigt som personalens stöd är avgörande för att dessa möjligheter ska bli möjliga i praktiken.

Schalock och Verdugo (2019) genomförde en internationell litteraturöversikt om livskvalitet och stöd till personer med funktionsnedsättning. De beskriver självbestämmande som en central del av livskvalitet, men betonar att det inte enbart kan förstås som en individuell rättighet, utan som en social process som formas i relationer och organisatoriska sammanhang. Vidare betonar Verdugo & Schalock (2019) att självbestämmande ska bidra till livskvalitet krävs personcentrerat stöd där individens preferenser uppmärksammas och omsätts i praktiken.

Samtidigt visar forskning att personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta har begränsade möjligheter att utöva faktiskt självbestämmande Mumbardo-Adam, Vincente, och Balboni (2020) genomförde en kvantitativ tvärsnittsstudie i Spanien och Italien med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, där resultaten visar att kognitiva svårigheter kan påverka förmågan att uttrycka preferenser, förstå konsekvenser av val och delta i beslutsfattande. Detta kan skapa en diskrepans mellan intention och praktik, där självbestämmande riskerar att bli symboliskt trots personcentrerade ambitioner (Mumbardo-Adam, Vincente, & Balboni, 2020). Studier visar även ett tydligt samband mellan autonomi, adaptiva förmågor och upplevd livskvalitet. Resultaten understryker personalens ansvar att skapa faktiska valmöjligheter, anpassa kommunikationen och stödja individens delaktighet (Mumbardo-Adam, Vincente, & Balboni, 2020).

Samtidigt problematiserar forskningen hur självbestämmande faktiskt kommer till uttryck i praktiken. Schalock och Verdugo (2019) betonar självbestämmande som en central del av livskvalitet, medan Mumbardó-Adam med flera (2020) visar att kognitiva svårigheter kan begränsa individens möjligheter att uttrycka preferenser och förstå konsekvenser av val. Detta pekar på en spänning mellan idealet om självbestämmande och de faktiska förutsättningar som finns i vardagen inom LSS-boenden, där självbestämmande riskerar att bli mer formellt än reellt.

Relationens betydelse i stöd

Forskning visar att relationen mellan personal och boende är grundläggande för hur stöd upplevs och fungerar i LSS-verksamheter. Trygghet, kontinuitet och förtroende i relationen underlättar för personalen att förstå individens behov och skapar förutsättningar för samarbete, delaktighet och ett mer förutsägbart vardagsliv. När relationen brister kan detta i stället leda till tillbakadragande, minskat samarbete och svårigheter att ta emot stöd (Topor, 2001).

Relationellt arbete lyfts fram som en central del av personcentrerat stöd. Zoffmann med flera (2016) genomförde en kvalitativ studie i Danmark med personer som lever med långvariga och kroniska sjukdomar, där fokus låg på personcentrerad vård och metoden Guided Self-Determination. Studien visar att individens delaktighet och egen förmåga stärks när stödet bygger på ett aktivt och strukturerat samarbete mellan personal och boende, där reflektion, lyhördhet och gemensamma mål står i fokus. När detta saknas riskerar delaktigheten att begränsas, vilket kan leda till passivitet, social isolering och minskad livskvalitet (Zoffmann med flera, 2016).

Även studier inom stödboenden visar att relationens kvalitet har stor betydelse för upplevelser av trygghet, delaktighet och självständighet. Brunt och Rask (2018) genomförde en kvantitativ studie i Sverige med personer som bor i LSS-bostäder, där resultatet visar att boendes upplevelse av livskvalitet i hög grad påverkas av personalens bemötande och relationella förhållningssätt. Vidare betonar De Lillo, Martin och Ferguson (2023), som genomförde en kvantitativ självskattning studie med äldre vuxna där nedsatt kognition kopplas till ökad ensamhet, att när relationen präglas av respekt och lyhördhet är den boende mer benägen att ta emot insatser och vara aktiv i sin vardag.

Topor (2001; 2005; 2016) genomförde kvalitativa studier i Sverige med personer med allvarlig psykisk ohälsa, deras närstående och ibland professionella stödpersoner, baserade på djupintervjuer och narrativa analyser. Studierna visar att återhämtning i hög grad är ett relationellt fenomen, där det inte främst är de formella insatserna som gör skillnad utan personalens närvaro, engagemang och vardagliga handlingar. När relationen präglas av maktobalans eller bristande förståelse ökar risken för att individen drar sig undan och tackar nej till stöd. Betydelsen av kontinuitet och tillit i stödjande relationer bekräftas även av Lindvig med flera (2021) genomförde en kvalitativ studie i Danmark där personal beskriver vad som kännetecknar hjälpsamma relationer i stödboenden. Studien visar att hjälpsamma relationer kännetecknas av kontinuitet, tillit och ett relationellt stöd som sträcker sig bortom det formella uppdraget. Brister i kommunikativt och emotionellt stöd kan leda till att individens behov förbises, vilket i LSS-verksamheter kan förstås som en form av relationell försummelse och påverka möjligheten till självbestämmande och delaktighet (Zoffmann med flera, 2016; Lindvig med flera, 2021).

Studierna visar att relationens betydelse ges olika innebörd beroende på analytiskt fokus, där vissa betonar långsiktig kontinuitet och förtroende som grund för att ta emot stöd, medan andra i större utsträckning lyfter bemötandets betydelse i enskilda möten, vilket påverkar hur ett nej till stöd förstås och hanteras i praktiken.

Orsaker till att boende tackar nej till insatser

Forskning visar att när personer i stödboenden tackar nej till stöd är detta sällan ett enkelt eller rationellt val, utan snarare ett uttryck för flera samverkande faktorer. Avböjande kan handla om bristande tillit, tidigare negativa erfarenheter, svårigheter i socialt samspel eller kognitiva utmaningar som påverkar förståelsen av insatsens syfte. Ett nej till stöd kan därmed förstås som ett kommunikativt uttryck för bakomliggande behov eller erfarenheter, snarare än som ovilja i sig.

Studier visar att brister i relationen mellan personal och boende är en central orsak till att stöd avvisas. Brunt och Rask (2018) genomförde en kvantitativ studie i Sverige med personer som bor i stödboenden enligt LSS, där resultaten visar att bristande tillit, känslan av att inte bli förstådd samt negativa erfarenheter av personal kan bidra till att insatser tackas nej till. Liknande resultat framkommer i en kvantitativ registerbaserad studie i Danmark av Lindvig med flera (2021), som omfattade vuxna patienter inom hälso- och sjukvården och visar att bristande kontinuitet och tillit i relationer kan leda till att individer drar sig undan stöd. Även Mumbardó Adam med flera (2020), i en kvantitativ tvärsnittsstudie i Spanien och Italien med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, visar att begränsat inflytande och tidigare erfarenheter av kontroll kan påverka viljan att ta emot stöd.

Topor (2016) visar att personer särskilt kan avstå stöd när relationen upplevs som kontrollerande eller när personalen inte förmår möta individens perspektiv, vilket kan förstärka symtom och bidra till social isolering. Vidare betonar Zoffmann med flera (2016), i en kvalitativ studie i Danmark med personer som lever med långvariga och kroniska sjukdomar, att personcentrerat arbete kräver ett aktivt och medvetet relationellt stöd. När detta brister riskerar individens behov att förbises,

vilket kan leda till passivitet och ökad social isolering. Även Dickard och Townley (2025), i en kvantitativ studie i USA med personer med allvarlig psykisk ohälsa som bor i stödboenden, visar att boende kan avstå stöd när insatser inte upplevs som meningsfulla eller respektfullt utformade utifrån individens önskemål.

Sammantaget pekar forskningen på att avböjande av stöd i stödboenden sällan kan förstås som ett individuellt motstånd, utan snarare som ett uttryck för relationella, organisatoriska och kommunikativa brister i stödet.

Autism, Theory of Mind och social isolering

Forskning visar att personer med autism har en ökad risk för social isolering, särskilt i vuxen ålder. Studier pekar på att sociala svårigheter inte enbart handlar om bristande vilja till gemenskap, utan om kognitiva och sociala förutsättningar som påverkar möjligheten att delta i sociala sammanhang.

Lo med flera (2025) genomförde en kvantitativ studie i Storbritannien med medelålders och äldre vuxna (40–86 år), både autistiska och icke-autistiska personer, där sambandet mellan autistiska drag, Theory of Mind (ToM) och social delaktighet undersöktes. Resultaten visade att autistiska drag har ett tydligt samband med både svårigheter i ToM och lägre upplevd social delaktighet. Studien visar även att ToM delvis förklarar sambandet mellan autistiska drag och social isolering, vilket innebär att svårigheter att förstå andras tankar, känslor och avsikter kan bidra till att personer drar sig undan eller får svårt att upprätthålla sociala relationer (Lo med flera, 2025). Detta resonemang bekräftas av tidigare forskning som visar att många vuxna med intellektuell och utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning upplever ensamhet och svårigheter att skapa och behålla sociala relationer, trots en vilja att vara delaktiga. Lo, Happe´ och Stewart (2025) genomförde en kvantitativ studie i USA med vuxna personer med intellektuell och utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning, där själv- och närståendeskattningar användes för att undersöka livskvalitet och sociala erfarenheter. Resultaten visade återkommande upplevelser av ensamhet och begränsade sociala nätverk. Liknande resultat framkommer i en kvantitativ enkätstudie av Stewart med flera (2024) med autistiska vuxna, som visar att många upplever begränsade möjligheter till meningsfulla sociala kontakter, vilket kan förstärka känslan av utanförskap.

Sambandet mellan ToM och social delaktighet återfinns även i forskning utanför autismfältet. Lecce med flera (2015) genomförde en kvantitativ experimentell studie i Italien, där deltagarnas ToM-förmåga mättes med standardiserade uppgifter och kopplades till socialt fungerande. Studien visade att mer utvecklad ToM är förknippad med bättre förmåga att tolka sociala signaler och delta i sociala sammanhang. På liknande sätt genomförde De Lillo, Martin och Ferguson (2023) en kvantitativ tvärsnittsstudie i Storbritannien med äldre vuxna, där ToM-tester kombinerades med självskattningar av social delaktighet. Resultaten visade att starkare ToM-förmåga hänger samman med större trygghet i sociala situationer och lägre grad av ensamhet.

Sammanfattningsvis visar forskningen att både kognitiva förmågor och sociala villkor påverkar möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Svårigheter i

Theory of Mind framstår som en viktig faktor bakom social isolering hos personer med autistiska drag, vilket understryker behovet av anpassat och långsiktigt stöd för att möjliggöra sociala relationer inom ramen för LSS-verksamheters ansvar att främja delaktighet och jämlika levnadsvillkor (Lo med flera, 2025).

Kompetens och professionellt ansvar i praktiken

Forskning visar att personalens kompetens och professionella ansvar är avgörande för kvaliteten i stödet inom stödboenden. Hur personalen arbetar i praktiken, vilka metoder som används och hur dessa omsätts i vardagen påverkar i hög grad boendes delaktighet, trygghet och möjlighet att ta emot stöd. Två arbetssätt som särskilt lyfts fram i forskningen är Positive Behavior Support (PBS) och Active Support, vilka syftar till att skapa struktur, förutsägbarhet och individanpassat stöd.

Strydom, Bosco och Vickerstaff (2020) visar att personalens kompetens är en central faktor för att förebygga situationer där boende tackar nej till stöd, även när hälsa eller säkerhet riskerar att påverkas negativt. Studien visar att kunskap om beteenden, metodförståelse och förmåga att tolka bakomliggande orsaker till motstånd gör det lättare för personal att uppmärksamma tidiga signaler och anpassa sitt bemötande. Utbildning i PBS framhålls som särskilt betydelsefull, då metoden ger personalen verktyg för att arbeta proaktivt, identifiera stress och oro samt utveckla strategier som minskar risken för utmanande beteenden (Strydom, Bosco, & Vickerstaff, 2020). Ökad kompetens bidrar därmed till mer trygga och förutsägbara miljöer och minskar behovet av akuta insatser.

Askheim, Bengtsson och Bjelke (2014) belyser hur personal ofta hamnar i etiska dilemman där självbestämmande och omsorgsansvar står i konflikt. Ett nej från den boende kan både uttrycka autonomi och signalera utsatthet eller behov av stöd. Studien visar att professionellt ansvar inte enbart handlar om riktlinjer och beslut, utan om hur personal tolkar situationer. Vidare hur de närmar sig den boende och väger respekt för självbestämmande samt mot ansvar för säkerhet och välbefinnande i det dagliga arbetet (Askheim, Bengtsson, & Bjelke, 2014).

Forskning om Active Support visar att arbetssättet kan öka delaktighet, aktivitet och valmöjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning i LSS-boenden (Aspling, 2025; Beadle Brown med flera, 2012). Studierna betonar betydelsen av praktiknära ledarskap, där handledning och metodstöd ges i det dagliga arbetet. När ledarskapet är närvarande och vardagsnära blir det lättare för personalen att omsätta värdegrund, lagstiftning och arbetssätt i konkreta handlingar (Aspling, 2025; Mansell & Beadle Brown, 2012).

Ett gemensamt förhållningssätt och tydlighet minskar även risken för försummelse och andra missförhållanden. Otydlighet, osäkerhet och individuella tolkningar av uppdraget framstår som riskfaktorer. Medan stabilt praktikledarskap fungerar som en viktig skyddsfaktor för både boende och personal (Aspling, 2025; Mansell & Beadle Brown, 2012).

Forskningen visar att kvaliteten i stödet inom boende verksamheter formas i samspelet mellan självbestämmande, relationellt arbete och personalens professionella kompetens. Delaktighet och inflytande är centrala för livskvalitet, men förutsätter trygga relationer där stödet upplevs som meningsfullt och individanpassat. När relationer brister eller stödet ges utan tillräcklig lyhördhet kan detta leda till motstånd, tillbakadragande och att insatser tackas nej till. Samtidigt framstår personalens kompetens, metodanvändning och praktiknära ledarskap som avgörande för att förebygga sådana situationer. Ett professionellt och relationellt arbetssätt är därmed en grundförutsättning för hållbar kvalitet i stödet.

Organisatoriska villkor- risk för social isolering

Priebe med flera (2019) genomförde en tvärsnittsstudie i Storbritannien med enkäter och intervjuer, den riktade sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i stödboenden i Storbritannien.
Priebe med flera (2019) betonar att autonomi och livskvalitet hänger nära samman med organisatoriska förutsättningar. Vidare att autonomi och livskvalitet i stödboenden inte enbart formas i mötet mellan personal och boende. Utan de påverkas även av organisatoriska ramar såsom bemanning, resurser och styrning.

Betydelsen av sociala aktiviteter och stödjande relationer bekräftas i en internationell översiktsstudie av Gardiner med flera (2018), baserad på studier främst från Storbritannien, som fokuserar på äldre personer. Översikten visar att sociala aktiviteter och relationellt stöd kan minska ensamhet och social isolering, men att insatser ofta blir ojämna och varierar mellan verksamheter. Detta kopplas till otydlig styrning och bristande organisatorisk samordning (Gardiner, Geldenhuys, & Gott, 2018).

Liknande slutsatser återfinns i en översiktsstudie från Australien av Herrman med flera (2024), som analyserar forskning om psykosociala stödinsatser i samhället (community living) för personer med svår psykisk ohälsa. Studien visar att psykosociala insatser kan stärka delaktighet, självständighet och återhämtning, och betonar att sådant stöd bör vara personcentrerat och återhämtningsinriktat samt integrerat i vardagen på stödboenden. När dessa insatser inte prioriteras riskerar individens delaktighet att minska (Herrman med flera, 2024).

Även Mazza med flera (2016) visar på relationers och vardagsnära insatsers betydelse. De genomförde en kvantitativ observationsstudie i Italien med fokus på personer med svår psykisk ohälsa som lever i boenden i samhället, där resultaten visar att stödjande relationer och psykosociala insatser i vardagen är centrala för delaktighet och återhämtning. Studien betonar att gemenskap i boendemiljön kan motverka social isolering genom att erbjuda inkluderande sociala sammanhang. Detta indikerar att verksamheter som satsar på relationellt och vardagsnära stöd också kan minska risken för missförhållanden (Mazza med flera, 2016).

Sammanfattande reflektioner

Den forskning som presenterats i detta kapitel är särskilt relevant för denna studie eftersom den belyser centrala faktorer som påverkar möjligheten till självbestämmande och delaktighet i LSS-boenden. Forskningen visar att ett nej till

stöd sällan kan förstås isolerat eller enbart som ett uttryck för ovilja, utan behöver ses i relation till tidigare erfarenheter, relationella villkor och hur stödet utformas i praktiken. Detta perspektiv är av betydelse för studiens syfte, då fokus ligger på att förstå personalens upplevelser av när boende tackar nej till insatser och vilka utmaningar detta skapar i vardagsarbetet.

Samtidigt finns anledning att problematisera hur väl delar av den internationella forskningen kan överföras till en svensk LSS-kontext. Flera av de studier som refererats är genomförda i andra länder med olika välfärdssystem och organisatoriska förutsättningar än de som råder inom svensk funktionshinderomsorg. Även om grundläggande principer om självbestämmande, delaktighet och personcentrerat stöd är gemensamma, kan skillnader i lagstiftning, styrning och resurstilldelning påverka hur stödet faktiskt ges och upplevs i praktiken. Det innebär att forskningsresultaten behöver tolkas i ljuset av LSS-lagstiftningens intentioner och de villkor som präglar svenska grupp- och servicebostäder.

Forskningen synliggör också en återkommande spänning mellan självbestämmande och omsorgsansvar där personalen ofta behöver förhålla sig till situationer där en boendes nej både kan ses som ett uttryck för autonomi och som en signal om sårbarhet eller behov av stöd. Denna spänning, som belyses i flera studier, påvisar relevansen i etiska och professionella överväganden i det dagliga arbetet, särskilt när personalen upplever att hälsa, trygghet eller social delaktighet riskerar att påverkas negativt. Mot denna bakgrund blir relationellt arbete, professionell kompetens och organisatoriska förutsättningar centrala faktorer för hur sådana situationer hanteras i praktiken.

Sammantaget bidrar detta kapitel med en teoretisk och empirisk ram som möjliggör en fördjupad förståelse av de komplexa villkor som präglar stöd i LSS-boenden. Denna ram utgör därmed en grund för den fortsatta analysen av personalens erfarenheter och upplevelser i studiens empiriska material.

4. TEORI

Det teoretiska ramverket i studien utgår från tre kompletterande perspektiv: omsorgsetik, omsorgsrelationer och gräsrotsbyråkrati. Tillsammans belyser dessa perspektiv hur självbestämmande, relationellt arbete och organisatoriska villkor samspelar i stödboenden enligt LSS. Detta teoretiska ramverk används för att förstå hur personalens resonemang formas i mötet med boende som tackar nej till stöd. Ramverket används även för at belysa hur risk för missförhållanden kan uppstå när relationella och organisatoriska faktorer samverkar

Det teoretiska ramverket används även som ett analytiskt verktyg i studiens analys, genom att belysa hur personalens resonemang, tolkningar och handlingsstrategier kan förstås i ljuset av etiska överväganden, relationella processer och organisatoriska villkor. Varje perspektiv bidrar därmed med analytiska begrepp som används för att tolka personalens sätt att beskriva orsaker till att boende tackar nej till stöd, deras attityder och värderingar, samt de arbetssätt som tillämpas i vardagen.

4.1 Omsorgsetik

Omsorgsetiken synliggör att personalens arbete präglas av återkommande etiska dilemman. Perspektivet bidrar till att förstå varför personalens resonemang ofta är komplexa och ibland präglade av osäkerhet. Detta blir särskilt tydligt i situationer där självbestämmande behöver vägas mot ansvar för den boendes trygghet och välbefinnande. Sådana etiska avvägningar påverkar både relationen mellan personal och boende och den boendes möjlighet att ta emot stöd.

Både Noddings (1986) och Tronto (1994) utgår från att omsorg är grundläggande omsorg är grundläggande mänsklig praktik och alltid sker i relation till andra. De betonar att omsorg kräver lyhördhet, ansvar och en vilja att svara på den andres behov, samt riktar kritik mot samhällen där självständighet övervärderas och beroende betraktas som något negativt. Hos båda förstås omsorg inte som ett undantag, utan som en förutsättning för att människor ska kunna leva och utvecklas (Noddings, 1986; Tronto, 1994).

Samtidigt skiljer sig deras fokus och analytiska nivå. Noddings (1986) riktar uppmärksamheten mot det nära mötet och beskriver omsorg som en relationell och känslomässig process som formas i den direkta interaktionen mellan två personer. Hon betonar närvaro, empati och betydelsen av att bli sedd, där kvaliteten i mötet avgör hur omsorgen upplevs. Tronto (1994) har däremot ett bredare perspektiv och menar att omsorg alltid är inbäddad i samhälleliga och organisatoriska strukturer som rör ansvar, makt och resursfördelning. Hennes omsorgsetik synliggör därmed hur villkoren för omsorg påverkas av organisation, styrning och politiska prioriteringar.

I senare arbeten vidareutvecklar Tronto (1993; 2013) omsorg som en process som omfattar att uppmärksamma behov, ta ansvar, ge omsorg och följa upp hur omsorgen tas emot. Dessa steg är inte neutrala, utan kräver tolkning, omdöme och etiska överväganden. Här är även Noddings (1984; 2002) central genom sin betoning av omsorg som en relationell hållning snarare än enbart en handling. I situationer där boende tackar nej till stöd blir denna hållning särskilt betydelsefull, eftersom tillit, kontinuitet och lyhördhet kan avgöra om omsorg avvisas eller tas emot.

Inom ramen för denna studie används omsorgsetiken för att analysera hur personalen resonerar och agerar i praktiken i situationer där boende tackar nej till stöd. Perspektivet möjliggör en tolkning av de etiska överväganden som uppstår i spänningen mellan respekt för självbestämmande och ansvar för omsorg, trygghet och riskförebyggande arbete, där ett nej både kan förstås som ett uttryck för autonomi och som en signal om sårbarhet eller behov av omsorg.

4.2 Omsorgsrelationellt perspektiv

Ekebergh (2022) och Isenberg och Stenberg (2013) utgår från olika teoretiska grunder men bidrar tillsammans till ett omsorgsrelationellt perspektiv. Ekebergh utgår från ett livsvärldsperspektiv med rötter i fenomenologin och vårdvetenskapen, där omsorg förstås som något som skapas i det mellanmänskliga mötet och utifrån individens egen upplevelse. Isenberg och Stenberg (2013) har sin grund i socialpsykologin och beskriver relationen som ett samspel mellan

människor där ömsesidighet, tillit och ett etiskt förhållningssätt är centrala för att stärka individens självbestämmande. Tillsammans synliggör dessa teorier både individens upplevelse och det sociala samspelet i omsorgsrelationen.

Isenberg och Stenberg (2013) betonar att omsorgsrelationen utgör en grundläggande del av omsorgsarbete och är särskilt central inom LSS och socialpsykiatri där stöd ofta ges i nära och långvariga relationer. Relationens kvalitet påverkar inte bara hur stöd ges utan också hur det tas emot och tolkas. Vidare beskriver Isenberg och Stenberg (2013) att omsorgsrelationen som dynamisk och ömsesidigt formad, samtidigt som den präglas av en asymmetri där personalen bär ett professionellt ansvar som den boende inte delar. Detta innebär att personalens sätt att närma sig, kommunicera och tolka den boendes uttryck får stor betydelse för relationens utveckling och för hur stödinsatser upplevs. Ett nej kan därmed förstås som ett relationellt uttryck snarare än ett isolerat beslut (Isenberg & Stenberg, 2013).

När en boende tackar nej till stöd behöver detta därför förstås relationellt. Ett nej är sällan entydigt utan kan uttrycka självbestämmande, men också bristande tillit, tidigare negativa erfarenheter eller känslomässig överbelastning. Isenberg och Stenberg (2013) betonar att relationer skapas och omskapas i varje möte, vilket innebär att ett nej inte är statiskt utan måste förstås i sitt sammanhang. I omsorgsrelationen blir personalens förmåga att vara lyhörd, läsa av och anpassa sig efter den boendes behov avgörande. Det handlar inte om att övertala, utan om att skapa en relation där den boende kan närma sig stöd i sin egen takt. Ekebergh och Dahlberg (2022) betonar att livsvärldsperspektiv fördjupar förståelsen av relationens betydelse i dessa situationer. De betonar att omsorgsgivaren behöver vara öppen för den andres erfarenheter, även när dessa inte uttrycks tydligt i ord. Tystnad, undvikande eller motstånd kan vara sätt för den boende att visa hur situationen upplevs och hur stödet känns i stunden. För att relationen ska bli meningsfull krävs därför att personalen är närvarande och lyhörd, och har en genuin vilja att försöka förstå den andres livsvärld (Ekebergh & Dahlberg, 2022).

Omsorgsrelationen påverkas samtidigt av organisatoriska villkor. Isenberg och Stenberg (2013) lyfter betydelsen av tid, kontinuitet och stabilitet för relationens utveckling. Ekebergh (2022) betonar på liknande sätt att relationen kräver närvaro över tid för att trygghet ska kunna byggas. Bristande kontinuitet och hög personalomsättning kan därmed försvåra möjligheten att skapa den tillit som krävs för att en boende ska våga ta emot stöd. Relationella processer behöver därför förstås i relation till de strukturella ramar som omger omsorgsarbetet.

Det omsorgsrelationella perspektivet används i analysen för att förstå hur personalen tolkar och hanterar boendes avböjande av stöd som en del av en pågående relationell process. Perspektivet bidrar till att analysera hur personalens lyhördhet, kommunikativa förhållningssätt och förmåga att skapa trygghet påverkar möjligheten till delaktighet och hur social isolering kan utvecklas eller förebyggas i det vardagliga stödarbetet.

4.3 Gräsrotsbyråkrati

Enligt Michael Lipsky (2010) är en gräsrotsbyråkrat en offentligt anställd person som möter medborgare direkt i sitt dagliga arbete. Det kan till exempel handla om personal inom LSS och socialpsykiatri. Dessa yrkesgrupper har i praktiken stor betydelse för hur politiska beslut och lagstiftning genomförs i vardagen. Det är i mötet mellan personal och boende som beslut tolkas och omsätts i konkret handling.

I teorin om gräsrotsbyråkrati visar Lipsky (2010) hur personal i människonära verksamheter arbetar under organisatoriska villkor som ofta präglas av tidspress, begränsade resurser och otydliga mål. I sådana situationer behöver personalen hantera motstridiga krav. Å ena sidan finns ambitionen att ge individanpassat stöd (Lipsky, 2010). Å andra sidan finns organisatoriska ramar som begränsar handlingsmöjligheterna. För att få arbetet att fungera utvecklar personalen olika copingstrategier. Det handlar om sätt att prioritera och förenkla arbetet så att vardagen blir hanterbar. Dessa strategier får stor betydelse för vilka insatser den boende faktiskt får ta del av (Lipsky, 2010).

Lipsky (2010) beskriver också hur gräsrotsbyråkrater ofta behöver fatta beslut i stunden. Besluten tas med begränsad information och under press. Detta innebär att självbestämmande inte enbart kan förstås som en juridisk rättighet. I praktiken formas självbestämmande genom personalens bedömningar och prioriteringar i vardagen.

Ett centralt begrepp hos Lipsky (2010) är handlingsutrymme. Med handlingsutrymme menar han det utrymme som personal har att tolka regler, anpassa arbetssätt och fatta egna beslut i mötet med enskilda personer, även när det finns lagar och riktlinjer som styr verksamheten (Lipsky, 2010). Handlingsutrymmet ger möjlighet till flexibilitet och individanpassning. Samtidigt innebär det en risk. När organisatoriska krav blir styrande kan besluten i högre grad formas av tid och resurser än av den boendes behov.

När tid och bemanning inte räcker till utvecklar personalen strategier för att klara arbetet. I vissa fall kan detta leda till att insatser prioriteras bort. I praktiken kan social isolering då komma att normaliseras och uppfattas som ett acceptabelt utfall. Lipsky (2010) betonar att sådana normaliseringsprocesser inte uppstår av bristande engagemang. De uppstår som en konsekvens av att personalen försöker få vardagen att fungera under svåra organisatoriska förutsättningar.

När personalen tvingas prioritera mellan arbetsuppgifter eller när bemanningen är för låg riskerar relationellt arbete att nedprioriteras. Lipsky (2010) visar hur strukturella villkor påverkar personalens bedömningar. Dessa bedömningar görs ofta snabbt och under press. I praktiken avgör de vilka rättigheter och möjligheter den boende får ta del av. Självbestämmande blir därmed något som formas i mötet mellan individens vilja och personalens organisatoriska förutsättningar.

De tre perspektiven omsorgsetik, omsorgsrelationer och gräsrotsbyråkrati har valts för att analytiskt belysa hur personalens resonemang, attityder och hur personalen agerar i praktiken formas i situationer där boende tackar nej till stöd

och riskerar social isolering. Tillsammans synliggör perspektiven hur relationer, organisatoriska villkor samt etiska överväganden samspelar i praktiken.
Det teoretiska ramverket gör det möjligt att förstå hur personalens resonemang formas i situationer där boende tackar nej till stöd och riskerar att isolera sig. Genom att kombinera dessa perspektiv blir det tydligt att sådana situationer inte kan förstås utifrån en enskild faktor. I stället behöver både individens upplevelse, relationens betydelse och de organisatoriska förutsättningarna beaktas för att förstå hur stöd ges, tas emot eller uteblir.

Teorin om gräsrotsbyråkrati används för att analysera hur organisatoriska villkor såsom tidspress, bemanning och otydliga riktlinjer påverkar personalens handlingsutrymme i arbetet med boende som tackar nej till stöd. Perspektivet möjliggör en förståelse av hur personalens prioriteringar och strategier formas i mötet mellan lagstiftningens intentioner och verksamhetens praktiska förutsättningar, samt hur risk för normalisering av social isolering kan uppstå.

5. METOD

I denna del redogörs för studiens valda metod, tillvägagångssätt, urvalsprocess samt de metoder som använts för att bearbeta och analysera materialet. Avsnittet beskriver även litteratursökningar, studiens utmaningar och etiska överväganden.

Val av metod

Denna studie utgår från en kvalitativ metodansats. Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur personal inom LSS-boenden upplever och hanterar frågor om självbestämmande, social isolering och risk för missförhållanden. En kvalitativ metod bedömdes som mest ändamålsenlig eftersom den möjliggör insamling av rika och nyanserade beskrivningar av professionellas erfarenheter och resonemang (Bryman, 2016).

En kvantitativ enkätstudie övervägdes inledningsvis, men bedömdes inte vara tillräcklig för studiens syfte. Enkäter ger begränsade möjligheter att fånga komplexa aspekter som kroppsspråk, tonfall och känslomässiga uttryck, vilka är centrala för att förstå personalens upplevelser, värderingar och etiska överväganden i vardagsarbetet.

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2016) ger denna intervjuform en flexibel struktur där respondenternas perspektiv får stort utrymme. Fokus ligger på deras egna erfarenheter, tolkningar och uppfattningar, vilket bidrar till ett rikt och nyanserat empiriskt material. För att ytterligare fördjupa förståelsen valdes intervjuer av fenomenologisk karaktär. Detta innebär att intervjuerna utgick från respondenternas upplevelser av sin yrkesvardag, samtidigt som intervjuguiden användes som stöd (Kvale & Brinkmann, 2021).

Semistrukturerade intervjuer möjliggör att följa respondenternas resonemang och att ställa följdfrågor som fördjupar och klargör deras utsagor. Detta var särskilt betydelsefullt eftersom personalens erfarenheter varierar beroende på yrkesroll, arbetsplats, utbildningsbakgrund och tidigare möten med boende. Intervjuformen

gav även utrymme för att uttrycka känslor, värderingar och osäkerhet, vilket är centralt för studiens syfte.

Totalt genomfördes sex intervjuer. Två sektionschefer och fyra medarbetare, stödassistenter och stödpedagoger, som arbetar nära de boende i vardagen deltog i studien. Intervjuerna genomfördes antingen fysiskt eller via videomöten. Valet av intervjusätt påverkades av arbetstider och geografiska förutsättningar.
Att genomföra intervjuer med visuell kontakt bedömdes som viktigt. Möjligheten att ta del av ansiktsuttryck, kroppsspråk och emotionella reaktioner bidrog till en mer fördjupad förståelse av respondenternas utsagor. Detta var särskilt relevant i samtal som berörde relationer, ansvar och etiska dilemman, där subtila uttryck ofta har stor betydelse. Denna typ av nyanser hade inte kunnat fångas genom telefonintervjuer.

Informanterna

Totalt intervjuades sex personer som arbetar i stödboenden i Malmö och Ystad. Urvalet omfattade två sektionschefer och fyra boendenära medarbetare. Fördelningen mellan roller gav möjlighet att belysa både lednings- och vardagsperspektivet.

5.1.1 Tabell

Roll	Utbildningsbakgrund	Verksamhet	Kön	Ålder	Kommun
Sektionschef	Kandidatexamen / socionomexamen	Serviceboende (socialpsykiatri)	K	50-60	Malmö
Sektionschef	Kandidatexamen / socionomexamen	Gruppboende (LSS)	K	45-60	Malmö
Stödpedagog	Minst 90 hp relevant högskoleutbildning	Gruppboende	M	25-35	Malmö
Stödpedagog	Minst 90 hp relevant högskoleutbildning	Gruppboende	K	25-35	Ystad
Stödassistent	Gymnasial utbildning	Serviceboende	K	30-40	Ystad
Stödassistent	Gymnasial utbildning	Serviceboende	K	40-50	Malmö

Urval

I denna studie användes ett målinriktat och strategiskt urval för att identifiera respondenter som kunde bidra med relevant erfarenhet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2016) betonar att ett strategiskt urval är lämpligt när forskaren vill få tillgång till deltagare som har specifik kunskap eller erfarenhet av det fenomen som undersöks. Urvalet utformades därför för att fånga personalens erfarenheter av arbete i LSS-verksamheter, särskilt i situationer där boende tackar nej till stöd eller riskerar social isolering. För att säkerställa variation inkluderades personal från både LSS-gruppboende och serviceboende. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle arbeta inom LSS-gruppboende eller serviceboende, ha erfarenhet av att möta boende med autism och eller psykossjukdom samt ha erfarenhet av situationer där boende tackar nej till stöd eller drar sig undan från personalen. Bryman (2016) framhåller att urvalskriterier bör utformas i direkt relation till studiens syfte för att säkerställa att det empiriska materialet är relevant och meningsfullt. Det strategiska urvalet gjordes därför för att fånga både ett operativt perspektiv, från boendenära personal, och ett organisatoriskt perspektiv, från chefer med ansvar för verksamheten.

För att rekrytera respondenter användes snöbollsurval. Enligt Bryman (2016) innebär snöbollsurval att forskaren inleder kontakten med en eller ett fåtal personer som uppfyller studiens kriterier och som därefter kan rekommendera eller förmedla kontakt med ytterligare deltagare. Urvalet växer därmed successivt genom redan etablerade kontakter inom verksamheten. Bryman (2016) menar att denna urvalsmetod är särskilt användbar när studien riktar sig till en specifik yrkesgrupp eller när det krävs viss erfarenhet för att kunna bidra till studiens syfte.

I det inledande skedet användes en sektionschef som gatekeeper. Bryman (2016) beskriver en gatekeeper som en person som har tillträde till en organisation och som kan underlätta forskarens kontakt med potentiella respondenter. Gatekeepern fungerade i denna studie som en länk mellan forskaren och verksamheten och bidrog till att skapa legitimitet för studien samt möjliggöra kontakt med personal som uppfyllde inklusionskriterierna. Den första sektionschefen föreslog därefter ytterligare personer som kunde kontaktas via e-post för förfrågan om deltagande. I denna grupp intervjuades en sektionschef, en stödpedagog och ett stödbiträde. Därefter kontaktades forskaren av ytterligare deltagare som uttryckte intresse för att medverka efter rekommendation från kollegor. Bryman (2016) betonar att snöbollsurval ofta innebär att respondenter själva bidrar till att identifiera andra relevanta deltagare, vilket var fallet även i denna studie.

Urvalet omfattade respondenter med olika yrkesroller och erfarenheter från både serviceboende och gruppboende enligt LSS. Enligt Bryman (2016) kan variation i yrkesroller och erfarenheter bidra till ett mer nyanserat empiriskt material, vilket eftersträvades i denna studie.

Urvalets bredd bedömdes som tillräcklig eftersom båda formerna av LSS-boenden, gruppbostad och servicebostad enligt 9.9 § LSS, representerades. Variation i yrkesroll, utbildningsbakgrund och erfarenhet eftersträvades för att möjliggöra flera perspektiv på studiens frågeställningar.

Tillvägagångssätt

Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, eftersom denna metod gav respondenterna möjlighet att prata fritt utifrån sina egna erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2021). Intervjuformen skapade utrymme för dialog och gjorde det möjligt för mig att ställa följdfrågor när något behövde förtydligas eller fördjupas. Under intervjuerna försökte jag förhålla mig lyhörd och neutral, utan att lägga några värderingar i respondenternas svar (Bryman, 2016).

Innan intervjuerna skickades informationsbrev ut med information om studiens syfte och genomförande. Medan jag inväntade svar från de första respondenterna utformade jag intervjuguiden. Respondenterna fick ta del av studiens syfte, men inte de specifika intervjufrågorna i förväg. Detta var ett medvetet val, eftersom jag ville minska risken för att frågorna skulle diskuteras med kollegor eller chefer innan intervjun. Enligt Bryman (2016) kan sådana förhandsdiskussioner innebära yttre påverkan på respondenternas svar.

Intervjuguiden delades in i fyra teman: förebyggande arbetssätt, social isolering, relationer och självbestämmande. Till varje tema formulerades huvudfrågor och delfrågor. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor utifrån respondenternas

svar, vilket gjorde att intervjuerna fick olika fokus och innehåll. Detta upplevdes som viktigt för att få så mycket relevant empiri som möjligt och för att kunna besvara studiens syfte.

Jag valde att genomföra enskilda intervjuer, även de dagar då flera intervjuer genomfördes. En sektionschef intervjuades på sitt kontor och en annan via Teams med kamera. En stödpedagog intervjuades vid ett fysiskt möte, medan tre intervjuer genomfördes via Teams eller Zoom. Intervjuerna varade mellan 20 och 35 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafonapplikation på min iPad. Valet av inspelningsenhet grundades i att iPaden förvarades hemma och inte var tillgänglig för andra, vilket upplevdes som ett tryggare alternativ än en separat diktafon. Inspelningen godkändes av samtliga respondenter. Intervjuerna avidentifierades genom att tilldelas en bokstav och en siffra, varefter materialet transkriberades och analyserades.

Motivering till val av intervjuer med visuell kontakt

Intervjuerna genomfördes antingen fysiskt eller via videomöten, beroende på arbetstider och geografiska förutsättningar. Samtliga intervjuer genomfördes med visuell kontakt.

Valet att använda intervjuer med visuell kontakt grundades i studiens syfte och i min vilja att få en så nyanserad förståelse som möjligt av respondenternas upplevelser. Att kunna se deltagarna gjorde det lättare att uppmärksamma ansiktsuttryck, kroppsspråk och känslomässiga reaktioner, vilket kan ge ytterligare förståelse för det som sägs (Bryman, 2016).

I samtal som rör relationer, ansvar och situationer där boende tackar nej till stöd uttrycks erfarenheter ofta inte enbart genom ord, utan även genom pauser, tonfall och kroppsliga uttryck. Kvale och Brinkmann (2021) menar att intervjuer som syftar till att förstå människors upplevelser gynnas av närvaro och möjlighet till följdfrågor, något som underlättas genom visuell kontakt. Av dessa skäl valdes telefonintervjuer bort, då denna form hade begränsat möjligheten att fånga dessa mer subtila uttryck. Intervjuer med visuell kontakt bedömdes därför som mest lämpliga för att uppnå studiens syfte.

Bearbetning och Analys

Vetenskapsrådet (2024) beskriver etik som de principer som vägleder bedömningar av vad som är rätt och fel, medan moral handlar om hur dessa principer omsätts i praktiken. Inom forskning är etiska överväganden särskilt viktiga eftersom intervjuer kan innebära att deltagare delar känsliga erfarenheter eller befinner sig i en utsatt position. Som forskare har jag därför haft ett ansvar att skydda deltagarnas integritet, självbestämmande och värdighet.

I linje med detta strävade jag efter att utforma intervjuerna på ett sätt som inte skapade obehag, press eller känslomässig belastning. Samtidigt behövde studien genomföras så att den kunde bidra med kunskap som är relevant och användbar för verksamheter och yrkesverksamma inom LSS. Att väga potentiella risker mot studiens nytta är en viktig del av forskningsetiken och jag hade därför ett särskilt

ansvar att skapa en trygg intervjusituation och bemöta deltagarna med respekt och lyhördhet (Vetenskapsrådet, 2024).

Inför intervjuerna skickades två mejl till deltagarna där jag informerade om de fyra forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2024). Informationskravet innebar att deltagarna fick tydlig och begriplig information om studiens syfte, vad intervjuerna skulle handla om och hur materialet skulle användas. Jag informerade även om samtyckeskravet, vilket innebär att deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva ange någon anledning.

Vidare informerades deltagarna om konfidentialitetskravet. Detta innebar att allt material behandlades med sekretess och att inga namn eller andra identifierande uppgifter skulle förekomma i studien. Citat anonymiserades så att varken enskilda personer eller verksamheter skulle kunna identifieras. Jag informerade även om nyttjandekravet, vilket innebär att det insamlade materialet endast används för denna studie och inte i andra sammanhang (Vetenskapsrådet, 2024).

Jag valde att inte bifoga intervjuguiden i förväg, eftersom jag ville få så spontana och opåverkade svar som möjligt. Deltagarna informerades dock tydligt om sin rätt att avbryta deltagandet när som helst, vilket även framgår av informationsbrevet i bilaga 1. För att skydda deltagarnas identitet avidentifierades allt material och inga namn eller arbetsplatser redovisas i resultatet.

I analysen och resultatredovisningen har citat bearbetats varsamt för att bevara innehållet, men samtidigt säkerställa att deltagarna inte kan identifieras av kollegor, chefer eller andra. Genom detta arbetssätt har jag följt Vetenskapsrådets riktlinjer och strävat efter att deltagarnas medverkan inte ska medföra några negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2024).

Styrkor och begränsningar

Valet av en kvalitativ intervjustudie möjliggjorde en fördjupad förståelse av personalens resonemang, erfarenheter och etiska överväganden i situationer där boende tackar nej till stöd. En styrka med den valda metoden är att den gav utrymme för nyanser, osäkerhet och reflektion kring komplexa situationer som inte enkelt låter sig fångas genom standardiserade metoder. Samtidigt innebär det begränsade antalet intervjuer att studiens resultat inte kan generaliseras till alla LSS-verksamheter. I stället syftar studien till analytisk generalisering, där resultaten kan bidra till förståelse av liknande situationer i andra verksamheter med liknande kontextuella förutsättningar.

En ytterligare begränsning är att studien enbart bygger på personalens perspektiv. Boendes egna röster har inte inkluderats, vilket innebär att resultatet speglar hur personal uppfattar och tolkar situationer snarare än hur dessa upplevs av de boende själva. Detta val gjordes utifrån studiens syfte och de etiska utmaningar som kan uppstå vid intervjuer med personer i beroendeställning, men innebär samtidigt att vissa perspektiv saknas.

Alternativa metodologiska tillvägagångssätt hade kunnat vara deltagande observationer eller fokusgruppsintervjuer. Observationer hade kunnat ge ytterligare kunskap om hur stöd praktiseras i vardagen, men bedömdes svåra att

genomföra utifrån etiska överväganden kring integritet och boendes privatliv. Fokusgrupper hade kunnat bidra till gemensamma reflektioner bland personal, men valdes bort då ämnet rör etiska dilemman och potentiella missförhållanden, vilket bedömdes kunna hämma öppenhet i grupp. Mot denna bakgrund bedömdes individuella intervjuer vara det mest lämpliga tillvägagångssättet för studiens syfte, samt lämpligt i relation till studiens tidsmässiga ramar.

6. RESULTAT OCH ANALYS

Detta kapitel presenterar studiens resultat och analys integrerat. Syftet är att synliggöra hur personal inom LSS-boenden beskriver sitt ansvar och sina arbetssätt i situationer där boende tackar nej till insatser och riskerar att isolera sig.

Resultatet struktureras i fyra teman som framträdde i materialet*: relationellt och uppsökande arbete för att förebygga social isolering*, *orsaker till att boende tackar nej till insatser*, *attityder och värderingar kring självbestämmande* samt *metoder och rutiner för att förebygga social isolering*
.

6.1 Relationellt och uppsökande arbete för att förebygga social isolering

Resultat

Resultatet visar att personalen beskriver det relationella och uppsökande arbetet som den mest centrala förutsättningen för att förebygga social isolering. Relationens betydelse framträder som grundläggande för hela omsorgsarbetet och inte enbart som ett professionellt verktyg bland andra. Flera respondenter beskriver att utan en fungerande relation fallerar övriga insatser, och att relationen därför behöver byggas upp genom ett kontinuerligt och ofta tidskrävande uppsökande arbete.

En respondent beskriver hur relationsskapande ses som en nödvändig utgångspunkt i arbetet med boende som ofta tackar nej till insatser:
”Det skiljer sig så enormt från individ till individ. Men det är ju först och främst att hela tiden föreslå olika möten, föreslå träffar för att bygga relation, för om relationen inte finns där så fallerar allt annat och de säger nej oftare än sällan.” (P4)

Citatet visar hur relationen uppfattas som avgörande för om stöd överhuvudtaget kan erbjudas och tas emot. Resultatet visar vidare att relationsarbetet kräver att personalen vågar ge av sig själv i mötet med den boende. Flera beskriver vikten av att visa engagemang, nyfikenhet och ett personligt intresse:
”Ja, jag tänker att man behöver vara nyfiken och intresserad och behöver bjuda mycket på sig själv och vara lite personlig för att kunna få en relation och vara engagerad.” (C2)

Samtidigt framkommer att det uppsökande arbetet ofta behöver vara lågintensivt och anpassat efter den boendes aktuella förutsättningar. Kontakten kan vara

mycket begränsad, och personalen beskriver hur möten ibland präglas av korta tidsfönster och osäkerhet kring hur kontakten ska tas:
”Man hade några sekunder på sig och prata och sen stängdes dörren i ansiktet på en så att man alltid var tvungen att vara effektiv. För det mesta så var det svårt och de visste inte riktigt hur de skulle göra med den boende.” (P3)

Resultatet visar också att relationer ofta är personbundna, och att vissa medarbetare har lättare att nå fram till den boende än andra. I dessa situationer används personal med etablerat förtroende som en resurs i det uppsökande arbetet:
”Man behöver ju använda den starkaste personen med den finaste relationen, är den som får vara lite grann nyckeln in på något vis.” (SC1)

Förtroende och kontinuitet framstår som avgörande för att relationen ska kunna bestå även när kontakten periodvis är begränsad. En respondent beskriver hur arbetet ofta handlar om att hitta individuella vägar in i relationen:
”Jag har hittat vägar, alltså jag har hittat olika vägar, intresse som kan locka ut. Så, förtroende. Jag tror att förtroende är väldigt viktigt att ha.” (P4)

Bemötandet beskrivs ofta som kravlöst och anpassat efter individens motivation. Flera respondenter beskriver hur personalen försöker skapa kontakt genom lustfyllda och vardagsnära aktiviteter:
”Det är först och främst att man gör det på ett kravlöst sätt. Man går ju bredvid och ser hur det går till och sen börjar man med det minst kravlösa typ. Den vill spela spel eller titta på tv tillsammans eller gå på promenad, då är det ju en lustfull aktivitet som gör att man får en bra relation.” (P1)

Ett återkommande mönster i materialet är att ny personal ibland uppmärksammar behov och risker som blivit normaliserade inom arbetsgruppen. När nya perspektiv tillförs synliggörs situationer som tidigare tolkats som den boendes normala sätt att leva:
”Jag skulle först och främst säga att om vi vet att en boende alltid har föredragit att inte ha så mycket kontakt med personalen […] så ser en nytillkommen personal på någon slags nivå utifrån, så flaggar hen för att det här är inte bra.” (P4)

Analys

Analysen visar att det relationella och uppsökande arbetet utgör grunden för personalens arbete med att förebygga social isolering. Relationen framträder inte som ett komplement till insatserna, utan som den bärande förutsättningen för att stöd ska kunna erbjudas och tas emot. Detta innebär att omsorgsarbetet i hög grad formas i det mellanmänskliga mötet mellan personal och boende.

Ekebergh (2022) betonar att ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv enligt kan personalens beskrivningar förstås som ett uttryck för att omsorg uppstår i mötet där den boendes livsvärld tas på allvar. De lågintensiva, kravlösa och återkommande kontakter som beskrivs i materialet speglar ett förhållningssätt präglat av närvaro, uthållighet och lyhördhet. Relationen framstår som sårbar och beroende av kontinuitet över tid (Ekebergh, 2022).

Samtidigt visar materialet att relationen är ömsesidigt formad och påverkas av både personalens och den boendes agerande. I linje med Isenberg och Stenbergs

(2013) relationella socialpsykologi skapas och omskapas relationer i varje interaktion. Personalens sätt att tolka den boendes signaler och anpassa sitt bemötande får därmed stor betydelse för om relationen utvecklas eller försvagas. Att relationer ofta blir personbundna kan förstås utifrån relationernas historiska och situationsbundna karaktär. Tidigare erfarenheter och etablerat förtroende påverkar hur nya kontakter tas emot. Detta blir särskilt tydligt när personal med stark relation används som en resurs i det uppsökande arbetet (Isenberg & Stenberg, 2013).

Analysen visar också hur organisatoriska och kulturella faktorer inom personalgruppen påverkar det relationella arbetet. När isolering normaliseras över tid kan nya medarbetares perspektiv fungera som en viktig korrigerande faktor, detta ligger i linje med Topors (2001; 2005; 2016) beskrivning av hur vardagliga relationer kan bli så etablerade att förändringar i individens mående inte alltid uppmärksammas. Även Lindvig med flera (2021) visar att nya perspektiv ibland krävs för att omtolka situationer där personer dragit sig undan.

Relationellt och uppsökande arbete är avgörande för att förebygga social isolering i LSS-boenden. Relationen framträder som existentiellt betydelsefull snarare än enbart professionell och utgör den arena där självbestämmande, delaktighet och omsorg kan möjliggöras. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning som betonar relationens kvalitet, personalens närvaro och förmågan att ompröva invanda tolkningar som centrala faktorer för att förebygga social isolering (Topor, 2001; Brunt & Rask, 2018; Lindvig med flera, 2021).

Samtidigt innebär det starka fokus på relationer en sårbarhet, då tillgången till stöd blir beroende av individuella relationer snarare än av likvärdiga strukturer. När relationer är personbundna riskerar stödet att bli ojämnt fördelat, där vissa boende får tillgång till mer engagerat och uthålligt arbete än andra. Detta kan förstås som en konsekvens av att relationellt arbete i liten utsträckning ges organisatoriskt skydd och struktur, trots att det beskrivs som avgörande för att förebygga isolering.

6.2 Orsaker till att boende tackar nej till insatser

Resultat

Resultatet visar att personalen beskriver boendes nej till insatser som något komplext och sammansatt. Ett nej förstås sällan som ett tydligt och självständigt val, utan formas i ett samspel mellan flera olika faktorer. Personalen beskriver hur individuella erfarenheter, relationen till personalen, psykisk ohälsa, diagnosspecifika svårigheter samt verksamhetens organisatoriska förutsättningar tillsammans påverkar den boendes vilja och möjlighet att ta emot stöd. Nejet framstår därmed som situationsbundet och föränderligt, snarare än som ett entydigt uttryck för självbestämmande.

En återkommande orsak som lyfts fram i materialet är bristande förtroende för personalen. Flera respondenter beskriver hur tidigare erfarenheter av bemötande, liksom otrygghet i relationen, påverkar viljan att ta emot stöd. En respondent beskriver detta på följande sätt:

”Ja, det är brist på förtroende, att inte bli behandlad på det sättet man kanske skulle vilja att bli, kanske kan vara otryggt. Att ta emot hjälp av vissa personer. Timing kan det vara. Alltså vilken dagsform och just tiden. Ja, för att man inte kanske känner för det just nu då.” (P1)

Citatet visar hur nejet inte nödvändigtvis handlar om ett generellt motstånd mot stöd, utan om hur och när stödet erbjuds samt vem som erbjuder det. Timing, dagsform och relationens kvalitet framstår som avgörande.

Flera respondenter beskriver också att boende ibland upplever personalen som kontrollerande eller dömande, vilket kan förstärka motståndet mot insatser:
”En känsla av att vi kontrollerar dem, eller att vi har för mycket åsikter kring hur de lever sina liv, att de känner sig missförstådda, eller att de inte helt enkelt har energin.” (P4)

Resultatet visar vidare att hög personalomsättning och bristande kontinuitet påverkar boendes benägenhet att tacka nej till stöd. När relationer upplevs som kortvariga eller instabila minskar motivationen att investera i nya kontakter. En respondent återger hur detta uttrycks av en boende:
”Han konstaterade att det är för mycket byte av personal. Fast personal, timanställda, vikarier, det är för många. Och han sa det rakt ut, jag orkar inte lära känna fler nya människor, för de försvinner bara.” (SC1)

Psykisk ohälsa framkommer som en annan central orsak till att boende tackar nej till insatser. Flera respondenter beskriver hur perioder av försämrat mående kan leda till att boende drar sig undan som ett sätt att skydda sig själva:
”Att man går in i en period av ohälsa, till exempel för att det är jul […] och man kan också gå in i isolering för att skydda sig själv […] då tänker man att det är bättre att isolera mig, för då händer inte någonting.” (SC2)

I materialet framkommer även att diagnosspecifika svårigheter, särskilt kopplade till autism, kan påverka hur stöd uppfattas. Svårigheter i social förståelse och perspektivtagande kan göra det svårt att tolka personalens intentioner. En respondent beskriver detta som att det ibland är svårt att nå fram till individens behov:
”Andra tycker att de har inget behov av det, de ser inte sitt eget […] det är ganska svårt att tränga igenom.” (SC1)

Vidare framkommer att låg självkänsla och upplevelser av att vara till besvär påverkar hur boende förhåller sig till stöd. I vissa fall uttrycker boende att andra behöver insatserna mer:
”En har ett viktigt jobb, men där vi ser att han skulle behöva ett stöd med städ […] men han har sagt till personalen att han tycker att de ska ägna sig åt andra, de som behöver det bättre och han vill inte vara till besvär.” (SC1)

Samtidigt visar resultatet att vissa boende är tydliga med att de inte önskar någon relation med personalen, utan endast vill ha hjälp med specifika praktiska moment:
”Han var väldigt tydlig med att han inte ville skapa relationer med dem. Utan han ville bara ha hjälp med det han behövde ha hjälp med.” (SC1)

Resultatet visar även att alltför kravfyllda insatser kan upplevas som överväldigande, vilket leder till att boende tackar nej. En respondent beskriver hur insatser ibland behöver delas upp och göras mer konkreta:
”Det kan ju vara så att personen i fråga känner att det är en kravfylld insats […] Man behöver dela upp det så att den ser det mer konkret, kanske, som genom bildstöd.” (P2)

Analys

Analysen visar att boendes nej till insatser inte kan förstås som ett entydigt uttryck för självbestämmande. Snarare framträder nejet som ett meningsfullt uttryck format i ett samspel mellan individuella erfarenheter, relationella processer, psykisk ohälsa, kognitiva svårigheter och organisatoriska villkor.

Ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv (Ekebergh, 2022) kan boendes nej förstås utifrån hur situationen upplevs i den egna livsvärlden. När stöd upplevs som otryggt, kontrollerande eller saknar mening kan nejet fungera som ett sätt att skydda sig själv. Resultatet visar att boende ibland saknar energi, känner sig missförstådda eller inte upplever tillit till personalen, vilket påverkar viljan att ta emot insatser.

Relationens kvalitet framträder som avgörande för hur stöd tolkas. I linje med Isenberg och Stenbergs (2013) relationella socialpsykologi formas handlingar i sociala sammanhang och påverkas av tidigare erfarenheter. När relationer präglas av bristande kontinuitet eller negativa erfarenheter minskar möjligheten att bygga tillit, vilket i sin tur påverkar benägenheten att ta emot stöd.

För boende med autism och andra kognitiva svårigheter framträder även svårigheter i social förståelse som en betydelsefull faktor. Nedsatt förmåga till perspektivtagande kan innebära att personalens intentioner misstolkas, vilket kan leda till att stöd upplevs som påträngande eller hotfullt. Liknande mönster framkommer vid psykisk ohälsa, där förändrad verklighetsuppfattning och låg självkänsla kan påverka tilliten till personalen (Lo med flera, 2025).

Analysen visar också att organisatoriska faktorer, såsom personalomsättning och bristande kontinuitet, påverkar boendes vilja att ta emot stöd. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att stabila och långsiktiga relationer är centrala för att nå personer som drar sig undan stöd (Lindvig med flera, 2021).

Sammanfattningsvis visar analysen att boendes nej till insatser förstås som relationellt och situationsbundet. Nejet formas i ett komplext samspel mellan individuella förutsättningar och relationens kvalitet . Vidare att den påverkas av verksamhetens organisatoriska ramar. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att avvisande av stöd ofta är kopplat till relationella och strukturella faktorer snarare än ett aktivt och informerat val att avstå omsorg (Topor, 2001; Brunt & Rask, 2018).

Att nejet framstår som situationsbundet och relationellt utmanar en förenklad förståelse av självbestämmande som ett stabilt och självständigt beslut. I stället synliggörs ett behov av att förstå självbestämmande som något som förutsätter tillit, begriplighet och relationellt stöd. När nejet tolkas utan detta sammanhang

riskerar personalen att överskatta autonomin och underskatta behovet av fortsatt omsorg, vilket kan bidra till att isolering normaliseras snarare än uppmärksammas.

6.3 Attityder och värderingar kring *självbestämmande samt risk för social isolering*

Resultat

Resultatet visar att självbestämmande framträder som en central utgångspunkt i personalens resonemang, och flera kopplar detta direkt till LSS som rättighetslagstiftning. Självbestämmande beskrivs som en grundläggande princip där den boendes vilja ska vara vägledande vid planering och genomförande av stöd. Samtidigt lyfter personalen att uppdraget också rymmer ett ansvar att uppmärksamma risker, särskilt när ett nej till insats sammanfaller med tecken på social isolering och försämrat mående. I denna spänning mellan respekt för autonomi och omsorgsansvar framkommer att personalens tolkningar, värderingar och trygghet i uppdraget får stor betydelse för hur situationer förstås och hanteras.

I materialet framkommer att nej till insats i vissa fall tolkas som ett uttryck för att boende själv väljer isolering. Flera beskriver att personal kan landa i en förståelse där det uttryckta nejet blir ett slutgiltigt svar, och där isolering därmed riskerar att accepteras som en självvald livsform. Det uttrycks tydligt av P1, som beskriver hur personalen kan resonera:
”Eftersom man själv säger nej till insats, så uppfattade personalen att man själv väljer att vara isolerad.” P1

Ett liknande resonemang framkommer hos P2, som beskriver att ett nej ibland leder till att personalen avstår från fortsatt arbete:
”[…]men då tänker man nej, då vill boende inte liksom själv att ta emot insatsen. Då väljer man det själv” P2

Samtidigt visar resultatet att denna tolkning inte är självklar eller enhetlig. Flera respondenter beskriver en mer problematiserande hållning där nejet inte automatiskt förstås som en spegling av den boendes inre tillstånd eller behov. P4 ger ett exempel på hur personalen kan fastna i att utgå från vad som antas vara bra, samtidigt som personen i fråga har svårt att uttrycka behov och föreställa sig alternativ:
”Jag har gjort mig skyldig till det ibland, att fokusen ligger mer på vad som kan tänkas vara bra för den boende i stället för vad individen själv känner och har uttryckt […] personen i fråga har väldigt svårt med förändring, har väldigt svårt att uttrycka vissa behov själv. Och även om man frågar så är det svårt för den personen ibland att mentalisera eller föreställa sig ett alternativ scenario”. P4

Resultatet visar också att personalen ibland uppmärksammar att det som sägs inte alltid överensstämmer med det som känns eller med det som faktiskt skulle kunna vara hjälpsamt. P1 formulerar detta som att personalen ibland saknar ett bredare perspektiv på vad ett nej kan betyda:
”Eftersom man själv säger nej till insats, så uppfattar personalen, uppfattade att man själv väljer att vara isolerad. att man inte har den där större tanken att man,

*att det man uttrycker och säger kanske inte stämmer med det man känner eller så."*P1

Ett tydligt resultat är att osäkerhet och upplevd kompetensbrist påverkar hur personalen hanterar dessa situationer. SC2 beskriver att många medarbetare upplever att de saknar tillräcklig kompetens, vilket kan leda till att man tar till förenklade, ibland mindre ändamålsenliga arbetssätt:
"[…] jag tror också att många medarbetare känner att de inte har kompetensen. Och då tar man den kortaste vägen att då blir det lite bestraffnings pedagogik. Att man lutar sig mot det gamla sättet för att man är lite rädd för det nya och är ovan. Det behöver inte alltid vara att man tycker illa om eller så, utan det handlar mycket om osäkerhet". SC2

SC2 beskriver också att rädsla för att göra fel eller att sakna rutiner kan leda till passivitet, och att det i praktiken blir personalgruppens inställning som avgör om något görs:
*" Mycket personal är rädd att göra fel, så man gör ingenting, eller att det finns ingen rutin. Det beror mycket på personalgruppens inställning till sitt arbete".*SC2

Resultatet visar vidare att det kan uppstå spänningar i personalgruppen kring hur nära relationell man får vara. I vissa grupper skildras en splittring där någon försöker arbeta relationsnära och personligt, men ifrågasätts av kollegor. SC2 beskriver detta som en svår men central konflikt i uppdraget:
"och så finns det någon som vet precis hur man ska jobba och någon som förstår hur man ska jobba men blir ifrågasatt av sina kollegor och säger att du har kommit alldeles för nära och du är alldeles för privat och personlig, men vi måste vara personliga om vi ska klara detta uppdrag. […] ibland så kan det också bli att personal tycker att en boende får flytta härifrån, det fungerar inte. Man tänker på sig själv och sina behov. Ibland har jag mött personalgrupper som har sagt att han ska flytta, men det är inte vi som bestämmer vem som ska bo här, då behöver kanske du flytta på dig om du inte trivs med detta uppdrag, så kanske du måste flytta på dig för att den boende kommer inte flytta. Och det blir ju väldigt svåra diskussioner". SC2

Flera respondenter beskriver även att självbestämmande ibland används som en "sköld" som gör att plikten till omsorg och uthålligt arbete försvagas. SC2 uttrycker detta kritiskt och kopplar det samtidigt till kvarvarande institutionstänk och förenklade lösningar:
" På alla våra gruppbostäder har man en väldigt märklig inställning till att man ska vara självbestämmande och så gömmer man sig bakom det. Det vi har för mycket av institutionstänket kvar, att vi tycker att vi vet bäst och vi tar den kortast möjliga vägen i arbetet och det gör att vi missar väldigt mycket". SC2

Vidare visar resultatet också hur isolering i vissa fall normaliseras över tid och att varningssignaler kan ignoreras tills situationen eskalerar. P4 beskriver en process där flera röda flaggor fanns, men där arbetet reducerades till att "knacka och erbjuda" utan att man tog ett samlat grepp, vilket i sin tur bidrog till att den psykiska ohälsan förvärrades:
"[…] i några månader så kom det en hel del flaggningar och röda flaggor som signalerade att här är det på väg att gå ut för. Men eftersom personen själv ofta försökte undvika att svara när man knackade så blev det accepterat inom

personalstyrkan och vara att nöjd med vad vi kan göra […] så var det accepterat att du ska bara gå upp och knacka, du kommer inte få svar ändå, men du ska knacka och erbjuda socialt sällskap. Och det eskalerade till situationer där personens mentala ohälsa blev så illa att i olika affektutbrott […] vi var tvungna att ha dubbelbemanning och någonstans där, när det började hända och då togs det på allvar. Men innan dess pratade man inte, alltså det fanns en slags inlärd hjälplöshet kring den här personen. P4

Flera beskriver dessutom att uthållighet i uppsökande arbete påverkas av trygghet och engagemang i personalgruppen. SC2 formulerar det som att en rädd eller oengagerad grupp kan "ta tacksamt emot ett nej" och avsluta arbetet, medan en trygg grupp fortsätter:
"[…]en personalgrupp som är rädd eller inte är intresserad av sitt arbete märker man ju att man gärna tar tacksamt emot ett nej och så går man tillbaka och släpper. Men finns det engagemang och det finns trygghet i arbetsgruppen så ger man sig inte i första taget." SC2

Samtidigt framkommer också en normativ hållning hos flera om att inte överge boende som isolerar sig. P3 uttrycker detta som en viktig princip där tvång avvisas men uthållig motivation betonas:
"Man får inte överge dem, men man får heller inte tvinga dem till saker utan motivera." P3

Resultatet visar slutligen att personal upplever ett dilemma mellan att respektera nej och att samtidigt se att behov finns. P1 problematiserar idén om att någon som bor i boende kan betraktas som helt självgående, samtidigt som självbestämmande ska respekteras:
*"Självgående, jag vet inte, alltså jag anser att om man bor på ett boende, då är man inte riktigt i självgående. Alltså, man kan vara självbestämmande och det får man ju vara alltid"*P1

Analys

Analysen visar att personalens attityder och värderingar kring självbestämmande får en avgörande betydelse för hur risk för social isolering uppmärksammas och hanteras i praktiken. Självbestämmande framträder i materialet som ett begrepp som tolkas och tillämpas på olika sätt, vilket påverkar både graden av uthållighet i det uppsökande arbetet och hur personalen förstår sitt ansvar när en boende tackar nej till insatser. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att självbestämmande inom LSS inte är ett entydigt begrepp, utan formas i mötet mellan lagstiftning, professionella värderingar och praktiska förutsättningar (Socialstyrelsen, 2011; Brunt & Rask, 2018).

Ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv enligt Ekebergh (2022) kan boendes nej förstås som uttryck som behöver tolkas i relation till individens livsvärld och aktuella situation. När personalen i materialet beskriver att ett nej ibland tas som ett slutgiltigt besked, utan vidare reflektion kring psykisk ohälsa, kognitiva svårigheter eller tidigare erfarenheter, synliggörs en risk att handlingar tolkas bokstavligt snarare än meningsfullt. Ekebergh och Dahlberg (2022) betonar att omsorg kräver en lyhördhet för det som inte alltid kan uttryckas verbalt, vilket blir särskilt relevant i mötet med personer som har svårt att mentalisera eller föreställa

sig alternativa handlingsmöjligheter. Resultatet visar samtidigt att personalen själva är medvetna om denna problematik, då flera beskriver att det som sägs inte alltid överensstämmer med det som känns eller med det som skulle kunna vara hjälpsamt. Detta kan förstås som att självbestämmande riskerar att bli något formellt, i stället för något som behöver stödjas genom relationellt och motiverande arbete, vilket även tidigare forskning har visat (Topor, 2001; 2005; Schalock & Verdugo, 2019).

Vidare framkommer att osäkerhet och upplevd brist på kompetens påverkar hur personalen agerar i situationer där boende isolerar sig. Detta kan förstås i relation till Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati, där personal i människonära verksamheter fattar beslut under osäkra, komplexa och ofta motstridiga krav. När riktlinjer är otydliga och stödet från organisationen upplevs som begränsat, utvecklas strategier för att hantera osäkerhet, exempelvis genom att förenkla situationer eller acceptera ett nej utan vidare bearbetning (Lipsky, 2010). I empirin synliggörs detta genom beskrivningar av hur rädsla för att göra fel eller brist på rutiner leder till passivitet.

Analysen visar också hur självbestämmande ibland används som ett argument för att avstå från omsorgsansvar. Detta kan förstås som en normativ förskjutning där autonomi tolkas absolut, vilket minskar utrymmet för professionella bedömningar av risk och behov. Tidigare forskning har visat att en sådan tolkning kan bidra till att social isolering normaliseras, särskilt när relationella och organisatoriska faktorer inte tas i beaktande (Topor, 2001; Brunt & Rask, 2018).

När självbestämmande används som ett skäl för att inte gå vidare i arbetet kan det leda till att ansvar i praktiken skjuts åt sidan. I dessa situationer handlar det ofta inte om att personalen saknar omsorg, utan om att osäkerhet, rädsla för att göra fel och bristande stöd gör att ett nej accepteras för snabbt. På så sätt finns en risk att självbestämmande i praktiken blir ett sätt att skydda personalen från svåra beslut, snarare än ett stöd för den boendes faktiska delaktighet.

Relationella processer inom personalgruppen framträder som ytterligare en central faktor. I linje med Isenberg och Stenbergs (2013) relationella socialpsykologi formas förståelser och handlingsmönster i gemensamma tolkningar och gruppnormer. När det uppstår oenighet kring hur nära relationell personalen får vara, eller när relationsarbete ifrågasätts av kollegor så påverkas möjligheten att arbeta uthålligt. Vidare betonar Belin, (2013 att detta synliggör hur arbetet med självbestämmande och omsorg inte enbart sker i mötet med den boende, utan också i det kollektiva meningsskapandet inom arbetsgruppen.

Berättelserna om inlärd hjälplöshet och normalisering av isolering kan förstås som exempel på hur organisatoriska och relationella mönster över tid påverkar handlingsutrymmet. När upprepade nej kombineras med bristande stöd och osäkerhet kan ambitionen successivt sänkas, vilket ligger i linje med Lipskys (2010) beskrivning av hur copingstrategier utvecklas i pressade verksamheter. Forskning visar att sådana processer ökar risken för att missförhållanden uppstår genom underlåtenhet snarare än genom aktiva handlingar (Socialstyrelsen, 2013; (Askheim, Bengtsson, & Bjelke, 2014)

Sammantaget visar analysen att personalens tolkningar av självbestämmande formas i ett komplext samspel mellan individuella värderingar, kompetens,

relationella processer och organisatoriska villkor. Resultatet ligger i linje med Ekeberghs (2022) fenomenologiska livsvärldsperspektiv, Isenberg och Stenbergs (2013) relationella socialpsykologi samt Lipskys (2010) gräsrotsbyråkratiska teori. Vidare visar det hur otydliga tolkningar av ansvar kan bidra till att social isolering normaliseras i LSS-verksamheter. När självbestämmande däremot förstås som något som behöver stödjas genom relation, uthållighet och professionell bedömning framträder större möjligheter att uppmärksamma isolering som en risk snarare än som ett självvalt tillstånd.

6.4 Metoder och rutiner för att förebygga social isolering

Resultat

Resultatet visar att personalen använder flera olika metoder och arbetssätt för att förebygga social isolering, men att dessa ofta beskrivs som otydliga, otillräckliga eller svagt förankrade i verksamheten. Ett återkommande mönster är att motivationsarbete lyfts fram som den huvudsakliga strategin, samtidigt som det beskrivs som svårt att arbeta framgångsrikt med personer som isolerar sig mest. P3 uttrycker detta tydligt:
”Motivation kan vara lite svårt ibland. Vi har ingen riktig taktik på det mer än motivationsarbete. Men jag tycker inte att det fungerar jättebra bland de som faktiskt isolerar sig mest, faktiskt.” P3

Samtidigt framkommer att personalen ofta försöker arbeta personcentrerat genom att anpassa kontakt och aktiviteter efter individens intressen och dagsform, särskilt när den boende befinner sig i perioder av bättre mående. P4 beskriver hur sådana perioder kan användas som en möjlighet att skapa gemenskap och bryta isolering:

”Personen var väldigt så här att de gillade att spela, men de blev också väldigt deprimerade och kände att socialt så saknade de jättemycket. I de bra perioderna så lyckades vi få personen att komma ner. […] i alla fall där hade man en chans att jobba med det om man bjöd på lite saft och kakor, liksom personen gillade godis. Så om man kunde locka med en stund gemensamt och lite kaffe, så blev det ibland bättre i perioder.” P4

Resultatet visar också att personal och ledning betonar behovet av reflektion och omprövning när arbetssätt inte ger effekt. SC1 formulerar detta som en fråga om hur arbetsgruppen arbetar och om man behöver ändra metod eller bemötande:

”[…] hur jobbar man i gruppen, alltså hur jobbar personalen med det här? Kan man säga att vi bör göra något annorlunda eller att vi helt enkelt gör fel? Jag tänker ju att när man har kommit förbi det steget, det är ju det man måste, även då måste titta på, kan vi göra något annorlunda?” SC1

Ett starkt resultat är att rutiner för att tidigt upptäcka och följa upp risk för social isolering ofta saknas. Detta uttrycks särskilt från ledningshåll, där avsaknaden av strukturer för ”tidiga tecken” kopplas till oro för att man missar försämringar, såsom psykos, depression eller tillbakadragande. SC2 beskriver detta som en tydlig brist:

”Nej, vi har ju inte de här rutinerna för... Vi har inte det här med tidiga tecken. Vi har ingen sådan rutin på några av mina boende, vilket gör mig väldigt bekymrad. Och det är ju någonting som jag vill att vi ska utforma för varje person, att hur kan vi upptäcka när det är på väg att gå in i en psykos, eller en depression, eller bara isolering eller att vi behöver identifiera tecken tillsammans med den boende så att de när de mår bra, det är då vi ska bygga rutinerna ju.” SC2

I materialet framkommer också att frånvaron av gemensamma rutiner kan leda till att enskilda medarbetare, särskilt vikarier eller ny personal, behöver ta egna initiativ och skapa vägar framåt utan tydligt metodstöd. P4 beskriver hur hen upplevde att det inte fanns något att luta sig mot, och att arbetet därför behövde börja i relationen och i ett aktivt bemötandearbete:
”[…] där man på något sätt har hamnat i den felaktiga bilden att personen är nöjd med läget som det är. För där tycker jag det saknas. Och det upptäckte jag själv som vikarie, att det fanns ingenting att tillgå utan jag var bara tvungen att lära känna den här människan och fokusera på att jag är tillräckligt intresserad för att kunna bemöta personen på rätt sätt.” P4

Resultatet visar vidare att dokumentation och uppföljning används som ett verktyg för att förstå återkommande inställda insatser och tolka mönster över tid. P2 beskriver hur man går tillbaka i journalanteckningar och beteenderegistreringar för att förstå sammanhang och orsaker:
”så får man kolla i dokumentation vad som har hänt när den här personen har jobbat med den och varför insatserna inte har blivit av och vad som har hänt innan och så här. Där finns ju beteenderegistrering med, och i dessa fall är det ju bäst med koder”. P2

Tydliggörande pedagogik framkommer också som ett konkret arbetssätt för att minska missförstånd och göra insatser mer begripliga, exempelvis genom samtal, observation och bildstöd:
”Det är genom observation och samtal så att hen verkligen förstår vad som ska göras. Ja, det är samtal och bild-stöd och liknande så att den vet valmöjligheten”. P2

Ett annat resultat är att forum för delaktighet och dialog med boende kan försvinna, vilket beskrivs som problematiskt eftersom dessa forum tidigare gav möjlighet att fånga upp boendes upplevelser och behov. P3 beskriver att brukarmöten tidigare var en plats där de boende kunde komma till tals, men att detta har försvunnit:
”[…] förr så hade vi ju faktiskt att vi brukare fick vara med i brukarmötena, vilket jag tyckte var bättre. Och det har ju försvunnit nu, exempelvis. Jag vet faktiskt inte varför, men det var ett bra sätt ändå. Och det är ändå deras möte, liksom. Och där kommer jag också få reda på lite vad de tyckte och kände, och så. Om olika saker och vad de hade behövt för att må bra, eller komma ut mer, om de vill hitta på grejer, liksom. Men det har också försvunnit” P3

Resultatet visar även att arbetssätt som benämns som personcentrerade och återhämtningsinriktade inte alltid upplevs vara förankrade eller följas upp i personalgruppen. P4 beskriver en upplevelse av att man talar om arbetssätten men att det saknas teoretisk förankring och uppföljning i praktiken:
”Som återhämtningsriktat, personcentrerat, bla bla bla […] så har vi ju haft mycket debatter om vad vi anser är personcentrerat och vilket som är

återhämtningsinriktat. […] Jag är inte nöjd. Hur det fungerar i praktiken är att vi pratar om dessa arbetssätt, men jag tycker inte det förankras teoretiskt bra i personalstyrkan, så tycker jag det finns en avsaknad av uppföljning". P4

Samtidigt efterfrågas nya metoder och mer utvecklade arbetssätt. SC2 lyfter exempelvis Peer Support, styrkeanalyser och WRAP1, och betonar att metoder behöver utformas efter individ och att kartläggning och lärande efter händelser är centralt:
"man behöver ju utveckla nya arbetsmetoder, tänker jag. Jag tänker att vi behöver titta på till exempel Peer Support , hur de jobbar med styrkeanalyser och WRAP och att man behöver börja titta på människan, för allting handlar egentligen om det sociala. Det är det sociala du kan återhämta dig i. […] Så jag tror att det finns inga klara metoder, utan du behöver utforma en för var individ och se vad det är som behövs här. Sen den tydliggörande pedagogiken och grundläggande metoderna, de kan vi kanske titta på, men vi ska inte tänka att det bara är dem som gäller, utan vi behöver tänka nytt också. Men kartläggning, tänker jag, är ju jätteviktigt att när det varit händelser att man alltid gör en kartläggning för att lära sig. Det är egentligen det viktigaste i vårt arbete, tänker jag." SC2

Resultatet visar dessutom att lågaffektivt bemötande och uthållighet lyfts som viktiga förhållningssätt för att bibehålla relation och minska trösklar efter affektstarka situationer. P3 beskriver hur personalen behöver finnas kvar och inte överge, eftersom det annars blir svårare att återuppta kontakt:
"[…] sedan kommer ju affekten men man får ju, vid senare tillfälle kan det ju bli affekter och då får man ju jobba i sig igenom det. Och inte överger dem. Det är ju den främsta orsaken. Hen har en affekt av en orsak. Du kanske inte vet just då men du måste ju finnas där och jobba dig igenom den för annars blir det en sådan hög tröskel för dig och den boende att komma över nästa gång." P3

Slutligen visar resultatet att Lex Sarah ibland blir den tydligaste strukturen som aktiveras när isolering och underlåtenhet redan lett till allvarliga konsekvenser. P4 beskriver hur ett svårt fall ledde till upptäckt av missförhållanden och Lex Sarah:
"I vissa fall uppfattas isoleringen som så allvarlig att den leder till rapportering enligt Lex Sarah, vilket blir en metod: 'Vi har haft en hel del faktiskt och alltifrån det svåra fallet, ett svårt fall där vi egentligen aldrig blev insläppta och kunde upptäcka att en toastol hade slagit sönder och att det hade förfallit ganska illa och krävde en Lex Sarah.'" P4

SC1 beskriver också hur långtgående åtgärder såsom vräkning kan aktualiseras, där enhetschef involveras och där man betonar att man måste ha prövat så mycket som möjligt innan beslut tas:
"Skulle det gå så långt så att någon faktiskt blir vräkt, då blir ju enhetschefen inblandad för att, ja, i det ekonomiska systemet […] Men också för att innan ett vräkningsbeslut eller en sådan åtgärd tas så ska man ju ha gjort så mycket som möjligt. Och då måste man ju ta upp det också med enhetschefen, tänker jag. Så det brukar vi ju göra i vår ledningsgrupp". SC1

[1] WRAP (Wellness Recovery Action Plan) är ett självstyrt och personcentrerat verktyg som stödjer återhämtning genom att individen identifierar strategier för välbefinnande och krishantering (WRAP, 2026).

Analys

Analysen visar att metoder och rutiner för att förebygga social isolering i LSS-verksamheter behöver förstås som ett samspel mellan relationellt vardagsarbete och organisatoriska strukturer. Det som i resultatet framträder som en mångfald av arbetssätt – motivationsarbete, personcentrerade ingångar, tydliggörande pedagogik, dokumentationsgenomgångar, lågaffektivt bemötande och i vissa fall Lex Sarah – kan tolkas som försök att skapa fungerande stöd i situationer där gemensamma rutiner och systematik upplevs som bristfälliga. Detta ligger nära Lipskys (2010) beskrivning av gräsrotsbyråkratiskt arbete, där personal i människonära verksamheter behöver fatta beslut och improvisera under osäkra villkor och med motstridiga krav.

Ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv (Ekebergh, 2022) kan personalens betoning på anpassning, dagsform och ”bra perioder” förstås som ett uttryck för att stöd blir meningsfullt först när det möter individen i dennes livsvärld. Att arbeta med små, vardagsnära öppningar – som att skapa kontakt genom intressen, gemensamma stunder och lågintensivt bemötande – kan tolkas som ett omsorgsarbete där relationen är bärande och där närvaro och lyhördhet blir centrala (Ekebergh, 2022). Detta ligger även i linje med forskning som betonar att relationens kvalitet påverkar om stöd tas emot eller avvisas (Topor, 2001; Brunt & Rask, 2018), och att delaktighet och livskvalitet formas i sociala sammanhang som behöver vara stödjande (Schalock & Verdugo, 2019). Samtidigt synliggör resultatet att just denna flexibilitet riskerar att bli personberoende när gemensamma rutiner saknas. När P4 beskriver att det ”inte fanns ingenting att tillgå” och att arbetet därför bygger på individuella initiativ, framträder en organisatorisk sårbarhet: kvaliteten i det förebyggande arbetet blir beroende av enskilda medarbetares engagemang och erfarenhet. Detta kan kopplas till tidigare forskning som visar att förutsättningarna i boenden, såsom bemanning, tidspress och otydliga styrsignaler, sätter ramar för personalens handlingsutrymme och möjligheten att arbeta personcentrerat och relationsbaserat (Lipsky, 2010; Priebe med flera, 2019; Mansell & Beadle Brown, 2012). När dessa ramar är snäva ökar risken att arbetet blir reaktivt, och att personer som drar sig undan blir svårare att nå (Lindvig med flera, 2021).

Ett viktigt analytiskt fynd är avsaknaden av strukturer för tidiga tecken. När SC2 beskriver att det saknas rutiner för att upptäcka psykos, depression eller isolering i tid så synliggörs en problematik där förebyggande arbete riskerar att ersättas av åtgärder först när läget blivit allvarligt. Detta knyter an till Socialstyrelsens betoning på att verksamheter behöver arbeta systematiskt för att uppmärksamma risk för missförhållanden och vidta åtgärder innan skador uppstår (Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 2013). När Lex Sarah i materialet framstår som en ”tydlig metod” först vid allvarliga konsekvenser, kan det tolkas som att formella strukturer aktiveras sent, medan vardagsnära förebyggande rutiner saknar tydlighet. Det ligger i linje med forskning som visar att brist på organisatoriskt stöd och otydliga rutiner kan bidra till att risker normaliseras i stödboenden (Priebe med flera, 2019; Socialstyrelsen, 2011).

Analysen visar också att dokumentation och beteenderegistreringar fungerar som ett sätt att skapa kontinuitet och förståelse över tid, men att dokumentationens funktion kan pendla mellan lärande och ansvarshantering. I en gräsrotsbyråkratisk kontext (Lipsky, 2010) kan dokumentation förstås både som ett verktyg för

uppföljning och som en strategi för att hantera organisatorisk osäkerhet. Det blir särskilt relevant när personal samtidigt beskriver avsaknad av gemensamma rutiner, vilket gör att dokumentationen ibland får bära en större roll än vad den är avsedd för.

Vidare synliggör materialet att delaktighetsstrukturer kan försvagas när forum som brukarmöten tas bort. Ur ett relationellt perspektiv (Isenberg & Stenberg, 2013) blir detta betydelsefullt eftersom relationer och förståelser formas i återkommande interaktioner och gemensamma sammanhang. När boendes röster får mindre plats i gemensamma forum riskerar personcentrering att bli ett individuellt arbetssätt snarare än en gemensam kultur. Detta kan påverka möjligheten att upptäcka tidiga förändringar i mående och socialt deltagande, vilket också är centralt i forskning om delaktighet och relationell kvalitet i LSS-miljöer (Brunt & Rask, 2018; Schalock & Verdugo, 2019).

Analysen visar att personalens efterfrågan på nya metoder och bättre teoretisk förankring pekar på ett behov av kompetensutveckling och uppföljning. När P4 beskriver att personcentrerat och återhämtningsinriktat arbete diskuteras men inte förankras eller följs upp, synliggörs ett glapp mellan styrande ideal och faktisk praktik. Forskning pekar på att personcentrerat och lyhört stöd är avgörande för att motverka social isolering och stärka delaktighet (Zoffmann med flera, 2016; Strydom med flera, 2020), men att detta kräver organisatoriska förutsättningar som gör arbetet möjligt i vardagen (Lipsky, 2010; Priebe med flera, 2019). När dessa förutsättningar saknas ökar risken att arbetet blir fragmenterat, och att insatser blir mer beroende av enskilda personers kompetens och initiativ än av gemensamma rutiner.

Sammanfattningsvis visar analysen att Tema 4 rör en dubbelhet: personalen beskriver ett rikt, relationsnära arbete där man försöker motverka isolering genom motivation, anpassning och uthållighet, samtidigt som bristen på systematik, tidiga tecken och gemensamma rutiner gör att förebyggandet riskerar att bli ojämnt och reaktivt. I detta perspektiv framstår behovet av tydliga rutiner, gemensam metodförankring och kontinuerlig uppföljning som centralt för att minska risken att social isolering normaliseras och för att skapa mer likvärdiga förutsättningar för stöd inom LSS-verksamheter (Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 2013; Brunt & Rask, 2018; Lindvig med flera, 2021; Priebe med flera, 2019).

7. Metoddiskussion

Studiens syfte krävde en metod som kunde fånga personalens erfarenheter och resonemang i deras komplexa situationer. Således valdes en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer, eftersom denna metod ger utrymme för deltagarnas egna berättelser och samtidigt skapar struktur genom en intervjuguide (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2021).

Urvalet bestod av sex yrkesverksamma med olika roller inom LSS-verksamheter. Urvalets storlek innebär att resultaten inte kan generaliseras statistiskt, men det gav möjlighet till fördjupade beskrivningar och variation i perspektiv genom att både boendenära personal och chefer ingick (Bryman, 2016).

Min yrkesbakgrund inom området kan ha bidragit till att intervjusituationen blev tryggare för deltagarna och att deras berättelser kunde utvecklas mer öppet. Samtidigt finns alltid en risk att förförståelse påverkar vilka aspekter som uppmärksammas i analysen. För att hantera detta genomfördes analysen systematiskt med nära anknytning till empirin, samt med återkommande kontroll mot det transkriberade materialet (Bryman, 2016; Brinkmann, 2024).

Etiskt har studien genomförts med tydlig information om frivillighet, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och att materialet avidentifierades, i enlighet med forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2024).

8. DISKUSSION

Syftet med studien var att undersöka hur personal inom LSS-boenden upplever sitt ansvar och agerar i situationer där boende tackar nej till insatser och riskerar social isolering. Resultaten visar att relationella faktorer, individuella förutsättningar och organisatoriska villkor är ömsesidigt beroende, där brister i en dimension riskerar att förstärka problem i de övriga.

Resultaten visar att boendes nej till insatser inte kan förstås som ett entydigt uttryck för självbestämmande. I stället framträder nejet som relationellt och situationsbundet, format av tillit, tidigare erfarenheter samt psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att stöd ofta avvisas när relationen till personal präglas av bristande tillit eller upplevelser av kontroll (Topor, 2001; Brunt & Rask, 2018; Lindvig med flera, 2021). Studien bidrar dock med en fördjupad förståelse för hur även organisatoriska faktorer, såsom personalomsättning och bristande kontinuitet, kan förstärka dessa svårigheter och därmed påverka boendes benägenhet att ta emot stöd.

Vidare visar resultaten att personalens tolkningar av självbestämmande varierar och påverkas av kompetens, erfarenhet och trygghet i yrkesrollen. Otydliga tolkningar riskerar att legitimera passivitet i situationer där stöd behöver erbjudas, vilket kan bidra till att social isolering normaliseras. Detta överensstämmer med tidigare forskning som problematiserar hur självbestämmande kan användas som argument för icke-agerande inom stödboenden (Askheim, Bengtsson & Bjelke, 2014; Brunt & Rask, 2018). Samtidigt betonar Socialstyrelsen att personal har ett ansvar att agera vid risk för missförhållanden, även när den boende tackar nej till stöd (Socialstyrelsen, 2013).

När det gäller arbetssätt och rutiner visar resultaten att relationellt och uppsökande arbete utgör grunden för det förebyggande arbetet, men att insatserna ofta är personberoende och bristfälligt förankrade organisatoriskt. Detta innebär att det förebyggande arbetet blir sårbart och riskerar att variera beroende på enskilda medarbetares engagemang. Avsaknad av gemensamma strukturer kan bidra till att risker uppmärksammas först när situationer blivit allvarliga, vilket även framkommer i tidigare forskning (Priebe med flera, 2019).

Ekebergh och Dahlberg (2022) betonar betydelsen av uthållighet och kontinuitet i omsorgsrelationer. Genom att finnas kvar, ta små initiativ och skapa försiktiga

öppningar för kontakt kan relationen successivt byggas upp. Det handlar inte om att pressa fram förändring, utan om att ge den boende utrymme att närma sig stöd i sin egen takt (Topor & Borg, 2007). Relationens betydelse blir därmed särskilt tydlig i situationer där boende isolerar sig eller drar sig undan. Samtidigt förutsätter ett sådant arbetssätt att personalen ges tid och organisatoriska förutsättningar att arbeta relationsskapande. Ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv synliggörs boendes handlingar i relation till deras livssituation (Ekebergh, 2022), men perspektivet riskerar att underskatta hur organisatoriska ramar begränsar personalens handlingsutrymme. Här bidrar det gräsrotsbyråkratiska perspektivet till förståelsen av hur otydliga strukturer och begränsade resurser påverkar personalens möjligheter att omsätta ansvar i praktisk handling (Lipsky, 2010).

Sammanfattningsvis visar studien att arbetet inom LSS-verksamheter präglas av en komplex balans mellan respekt för självbestämmande och ansvar för omsorg. Studien bekräftar tidigare forskning men bidrar även med fördjupad kunskap om hur denna balans formas i vardagsnära situationer där boende tackar nej till stöd och riskerar social isolering.

9. Slutsats

Denna studie visar att personalens arbete inom LSS-verksamheter präglas av en komplex avvägning mellan individens självbestämmande och personalens ansvar att förebygga psykisk ohälsa och social isolering. Resultaten indikerar att avvisande av stöd sällan kan förstås som ett självklart uttryck för självbestämmande, utan snarare som situationsbundet och relationellt.

Relationellt och uppsökande arbete framträder som centralt i det förebyggande arbetet, samtidigt som organisatoriska villkor påverkar personalens handlingsutrymme. Studien bidrar med en fördjupad förståelse för hur ansvar, attityder, relationer och organisatoriska förutsättningar samverkar och samtidigt synliggör behovet av tydligare strukturer i form av gemensamma metoder och arbetssätt.

Resultaten tyder på att arbetssätt ofta finns på en övergripande nivå men inte alltid är tillräckligt implementerade eller förankrade i verksamheternas rutiner. Sammantaget pekar studien på behovet av gemensamma förhållningssätt och kontinuerligt värderingsarbete för att bättre kunna hantera och förebygga risk för social isolering inom LSS-verksamheter.

Referenser

Angberg, M., Dahlin, M., & Tunlind, P. (2023). *Positivt beteendestöd:PBS i teori och praktik inom LSS.* Fantasi & Fakta.

Arman, M. (2022). *Teoretiska grunder för vårdande.* Liber AB.

Askheim, O., Bengtsson, H., & Bjelke, B. (2014). Personal assistance in a Scandinavian context: Similarities, differences and developmental traits. *Scandinavian Journal of Disability Research, differences and developmental traits.*, 3–18.

Asplin, J. (2025). *More participation, choice making and meaningful activities in everyday life for people with intellectual disabilities?: Evaluation of Active Support and Frontline Practice Leadership in group homes in Sweden.* Marie Cederschiöld University.

Association, A. P. (2015). *Diagnostiska och statistiska manualen för psykiska störningar: DSM-5* (5 uppl.). Pilgrim Press.

Belin, S. (2013). *Relation före metod.* Dualis Förlag AB.

Bengtsson, H. (2008). *Politik, lag och praktik - implementeringen av LSS-reform.* Studentlitteratur.

Brinkmann, S. (2024). *Kvalitativa intervjuer.* Studentlitteratur.

Brunt, D., & Rask, M. (2018). Resident and staff perceptions of the content of their relationship in supported housing facilities for people with psychiatric disabilities. , 11, 673–681. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 673-681. doi:https://doi.org/10.2147/JMDH.

Brusén, P., & Printz, A. (2006). *Handikappspolitiken i praktiken.* Växjö: Gothia.

Bryman, A. (2016). *Social research methods.* Oxford: University Press.

Carlén, M., Palmqvist, L., & Puaca, G. (den 18 04 2023). Om aktörskap och självbestämmandets villkor inom LSS. *Social vetenskaplig tidskrift, 30*(4), ss. 861-881. doi:DOI: https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.4.5113

Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (2022). En livsvärdlsorienterad etik. i M. Arman, *Teoretiska grunder för vårdande* (ss. 105-115). Liber AB.

De Lillo, M., Martin, A. K., & Ferguson, M. J. (2023). Exploring the relationship between loneliness and social cognition in older age. *Social Psychology, 54*(2), 16-21.

Dickard, K. E., & Townley, G. (2025). Who puts the “support” in supportive housing? The relationship between housing staff support and resident experiences, and the potential moderating role of self-determination. *American Journal of Community Psychology. Advance online publication*, 1-13. doi:https://doi.org/10.1002/ajcp.70023

Egard, H., Nyström , C., Jensen , T. B., Magnusson, E., Holmdahl , A., & Sjöström, C. (2016). *En plan skapar inte delaktighet. Betydelsen av kommunikation, normer och relationer i utförande och planering av insatser enligt LSS.* Malmö Högskola.

Ejneborn Looi, G.-M., & Gabrielsson, S. (2018). *Bemötande i psykiatrin.* Gothia.

Ejneborn Looi, G.-m., & Gabrielsson, S. (2023). *Sjuksköterska i psykiatrisk heldygnsvård- lärobok för rebeller.* Studentlitteratur.

Ekebergh, M. (2022). Reflektionens roll för vårdande vård. i M. Arman, *Teoretiska gruder för vårdande* (ss. 274-278). Liber AB.

Ekebergh, M. (2022). Vårdande möten. i E. Arman, *Teoretiska grunder för vårdande* (ss. 138-144). Liber AB.

Ekebergh, M., & Dahlberg, K. (2022). Vårdande och lärande samtal. i M. Arman, *Teroretiska grunder för vårdande* (ss. 146-164). Liber AB.

European Union Agency for Fundamental Rights. (u.d.). Hämtat från https://fra.europa.eu/sv/content/eus-mekanism-under-fns-konvention-om-rattigheter-personer-med-funktionsnedsattning den 11 02 2026

Friberg, S., Geuken, Å. K., & Wächter, Y. (2019). *Schizofreni-Livet med en psykossjukdom.* Gothia.

Funktionsrätt Sverige. (den 09 02 2021). *Värdegrund.* Hämtat från https://funktionsratt.se/om-funktionsrattsverige/var-organisation/vardegrund/< PDF 2026

Gardiner, C., Geldenhuys, G., & Gott, M. (2018). *Loneliness and social isolation interventions for older adults: A scoping review of reviews. BMC Public Health* (Vol. 16). doi:https://doi.org/10.1186/s12889-017-4507-1

Gillberg, C. (2018). *Essence.* Natur & Kultur.

Hall, O., & Christensen, C. (2025). *Motiverande samtal inom LSS och socialpsykiatrin.* Gothia.

Herrman, H., Harvey, C., Amering, M., Allott, K., & Killackey, E. (2024). Psychosocial interventions to support community living: Rehabilitation, recovery, and rights. *Tasman's psychiatry*, 3443–3490.

Hickey , A., Crabtree, J., Stott, J., & Healy, D. (2017). Social withdrawal, communication difficulties and loneliness in adults with autism spectrum conditions. *AUTISM*. doi:https://doi.org/10.1177/1362361316653564

Isenberg, B., & Stenberg, H. (2013). *Relationell Socialpsykologi – Klassiska och Samtida Teorier* (1 uppl.). Liber.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2021). *Den kvalitativa forskningsintervjun* (3 uppl.). Studentlitteratur.

Lecce, S., Cavallini, E., Ceccato, I., Vecchi, T., & Pagnin, A. (2013). Beyond false belief: Theory of mind in young, young-old, and old-old adults. *The International Journal of Aging & Human Developmen*. doi:https://doi.org/10.2190/AG.76.3.a

Lindberg, L., & Grönvik, L. (2012). *Funktionshinderpolitik.* Studentlitteratur.

Lindvig, G., Topor, A., Bøe, T. D., & Larsen, I. B. (2021). " will never forget him": A qualitative exploration of staff descriptions of helpful relationships in supportive housing. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing,*, 326–334.

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the. *Administrative Theory & Praxis*, 1-4. doi:https://doi.org/10.1080/10841806.2022.2141020

Lo, G. H., Happe´, F., & Stewart, G. R. (2025). Theory of Mind Mediates the Association Between Autistic Traits and Social Isolation in Middle-Aged and Older Adults. *Autism Research, 18*(6), 1234-1244. doi: https://doi-org.proxy.mau.se/10.1002/aur.70036

Mansell, J., & Beadle-Brown. (2012). Observing practice leadership in intellectual and developmental disability services. *Journal of Intellectual Disability Research*, 689–703. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2012.01583.x

Marcelind , R., & Pålsson, C. (1998/1999). *Motion 1998/99:So349.* Sveriges riksdag.

Markström, U. (2003). *Den svenska psykiatrireformen.* Studentlitteratur.

Mazza, M., D'Avanzo, B., & De Risio, A. (2016). Group-apartments for recovery of people with psychosis in Italy: Democratic therapeutic communities in post-modern social communities. *International Journal of Mental Health*, 1-15.

Mumbardo-Adam, C., Vincente, E., & Balboni, G. (2020). Self-determination and quality of life of people with intellectual and developmental disabilities:

Past, present, and future of close research paths. *Journal of Intellectual & Developmental Disability,*, 295–308.
Nind , M., & Hewett, D. (1994). Access to communication: developing the basics of communication with people with severe learning difficulties through Intensive Interaction. *Child Language Teaching & Therapy*, 354-356 .
Noddings, N. (1986). *Caring.* University of California Press.
Priebe, S., Saidi, M., Want, A., Mangalore, R., Reininghaus, U., Pizzo, E., . . . Slade, M. (2019). Quality of life, autonomy, satisfaction, and costs associated with mental health supported accommodation services in England: A national survey.
Regeringen. (2000). *Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken Prop. 1999/2000:79.* Socialdepartementet.
Regeringen. (2021). *Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031.* Socialdepartementet. Hämtat från https://www.regeringen.se/contentassets/cf8af503cbbc499894549da09ea685af/strategi-for-systematisk-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken-under-2021-2031.pdf den 14 02 2026
riksdagen.se, R. /. (2001). *SFS 2001:453. Socialtjänstlagen (SoL).* Stockholm: Socialdepartementet.
rättsdatabaser, R. (2025). *Lagen.nu*. Hämtat från https://lagen.nu/2001:453#K5 den 12 08 2025
Socialdepartementet. (1993). *SFS 1993:387. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).* Stockholm.
Socialstyrelsen. (2011). *Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)*. Hämtat från https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
Socialstyrelsen. (2013). *Lex Sarah – Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om missförhållanden och risker för missförhållanden. Socialstyrelsen.* Hämtat från https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/b771c2ad93794c548db0ca50308a1e02/2014-1-24.pdf den 4 2 2026
Socialstyrelsen. (2018). *Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).* Hämtat från https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/icf/ den 10 03 2026
Socialstyrelsen. (2021). *Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning-Lägesrapport 2021* . Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen. (2024). *Begrepp inom området psykisk hälsa.* Hämtat från https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/19112a0be4af4a7ea813f2421c6e465c/2024-6-9186.pdf den 13 03 2026
Socialstyrelsen. (den 12 12 2025). *Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.* Hämtat från Socialstyresen: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20029-om-bostad-med-sarskild-service-for-vuxna-enligt-9--9-lagen-1993387-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade
Socialstyrelsen. (2025). *Individens behov i centrum – Ett stöd för att använda ICF och.* Hämtat från https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/fcc27789e7f14076a19fc9f312a3168d/2023-6-8666.pdf den 14 02 2026

Socialstyreslen. (den 4 12 2025). *Socialstyrelsen.* Hämtat från Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning-Lägesrapport 2024: https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/ca0324c13c664d1cb7ce02f1c01ea03e/2024-3-8994.pdf

Statens offentliga utredningar. (1992). *Välfärd och valfrihet : service, stöd och vård för psykiskt störda : slutbetänkande.* Socialdepartementet.

Strydom, A., Bosco, A., & Vickerstaff, V. (2020). Clinical and cost effectiveness of staff training in the delivery of Positive Behaviour Support (PBS) for adults with intellectual disabilities, autism spectrum disorder and challenging behaviour: Ra. *BMC Psychiatry*.

Topor, A. (2001). *Managing the contradictions: Recovery from severe mental disorders.* Stockholm: Stockholms universitet.

Topor, A. (2005). *Vad hjälper?* Natur & Kultur.

Topor, A., & Borg, M. (2007). *Relationer som hjälper-om återhämtningsprocesser vid svåra psykiska problem.* Lund: Studentlitteratur.

Tronto, J. C. (1994). *Moral Bounderies.* Routledge.

United Nations. (2006). *Department of Economic and Social Affairs- Social inclusion*. Hämtat från https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd den 04 02 2026

Verdugo, M. A., & Schalock, R. L. (2019). Quality of life and autonomy in disability services: A conceptual and measurement framework. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 1-10. doi:https://doi.org/10.1111/jppi.12247

Vetenskapsrådet, & Åkerman, J. (2024). *God forskningsed 2024.* Vetenskapsrådet.

WRAP. (den 14 03 2026). *Wellness Recovery Plan.* Hämtat från https://www.wellnessrecoveryactionplan.com/what-is-wrap/the-way-wrap-works/

Zoffmann, V., Storbækken, S., Hörnsten, Å., Graue, M., Rasmussen, B., Wahl, A., & Kirkevold, M. (2016). Translating person-centered care into practice: A comparative analysis of motivational interviewing, illness-integration support, and guided self-determination. *Patient Education and Counseling*, 400–407.

Tabell 1. Litteraturöversikt Tidigare forskning

	Författare & år	Metod	Målgrupp	Fokus / resultat
1	Schalock & Verdugo (2019)	Litteraturöversikt	Personer med funktionsnedsättning	Självbestämmande och livskvalitet formas i relationer och stöd.
2	Mumbardó-Adam mfl. (2020)	Kvantitativ	Barn/unga med IF	Självbestämmande och delaktighet i vardagsaktiviteter.
3	Vincente & Balboni (2020)	Kvantitativ	Personer med IF	Samband mellan självständighet, självbestämmande och livskvalitet.
4	Zoffmann mfl. (2016)	Kvalitativ	Personer med kroniska somatiska sjukdomar	Dialogbaserade relationer stärker delaktighet och egen förmåga.
5	Topor (2001; 2005; 2016)	Kvalitativ	Personer med psykisk ohälsa + närstående	Återhämtning formas i ömsesidiga relationer.
6	Lindvig et al. (2021)	Kvalitativ	Personal inom LSS	Relationens betydelse för att nå personer som drar sig undan.
7	Dickard & Townley (2025)	Kvantitativ	Personer med psykisk ohälsa	Varför individer tackar nej till stöd.
8	Lo mfl. (2025)	Kvantitativ	Personer med autism	Theory of Mind och svårigheter i socialt samspel.
9	Hickey mfl. (2017)	Kvantitativ	Personer med autism	Socialt undvikande och kommunikationssvårigheter.
10	Stewart mfl. (2024)	Kvantitativ	Personer med autism	Socialt tillbakadragande och vardagsfungerande.
11	Lecce mfl. (2015)	Kvantitativ	Personer med autism	Kognitiva faktorer bakom social isolering.
12	De Lillo mfl. (2023)	Kvantitativ	Personer med autism	Social förståelse och undvikande beteenden.
13	Strydom mfl. (2020)	Utvärdering	Personal inom LSS	PBS och kompetensutveckling.
14	Aspling (2025)	Utvärdering	Personal inom LSS	Active Support och kvalitet i stöd.
15	Mansell & Beadle-Brown (2012)	Utvärdering/kvalitativ	Personal inom funktionshinderomsorg	Praktikledarskap och kvalitet i vardagsstöd.
16	Priebe mfl. (2019)	Survey	Personal inom socialpsykiatri	Organisatoriska hinder för personcentrerat arbete.
18	Gardiner mfl. (2018)	Scoping review	Äldre vuxna (överförbart till LSS)	Definitioner av social isolering.
19	Herrman mfl. (2024)	Översikt	Vård och omsorg	Organisatoriska riskfaktorer.
20	Mazza mfl. (2016)	Kvalitativ	Personal inom omsorg	Stress, arbetsvillkor och risk för brister.

BILAGA 1 Informationsbrev

Bilaga 1. Informationsbrev

Projektets titel (obligatoriskt): Balansen mellan omsorg och självbestämmande -En kvalitativ studie om Lss verksamheternas ansvar.	**Datum:** **2025-11-18**
Studieansvarig/a: Indhira Fredlund **Din E-post** **Indhira4ever@gmail.com**	**Studerar vid Malmö universitet, Fakulteten vid hälsa och samhälle,** **205 06 Malmö, Tfn 040- 6657000** **Utbildning:Socionomprogrammet** **Nivå: Kandidat**

Jag heter Indhira Fredlund och läser Socionomprogrammet på Malmö Universitet. Jag har valt att skriva mitt examensarbete om hur personal inom LSS-boende och serviceboende upplever sitt ansvar och agerar när boende med autism och/eller psykossjukdom tackar nej till insatser och isolerar sig från personalen. Studien fokuserar särskilt på vilka arbetssätt och rutiner som tillämpas för att förebygga och hantera situationer där risken för missförhållanden uppstår. Jag intervjuar gärna personal inom LSS boende och serviceboende som arbetar nära de boende, vidare även ett par sektionschefer inom funktionsstödförvaltningen.

Intervjun beräknas ta cirka 40–60 minuter. Intervjun kommer att utgå ifrån en intervjuguide med öppna frågor. Jag vill gärna spela in intervjuerna, om du godkänner detta**.** Intervjumaterialet (inspelningar, anteckningar) kommer att avidentifieras och anonymiseras när intervjuerna transkriberas. Inspelningsmaterialet kommer att förstöras efter transkribering. När studien är klar i ca februari 2026 förstörs det inspelade och det utskriva materialet

Efter att uppsatsen har blivit godkänd kommer uppsatsen publiceras på DIVA som en portal för akademiska publikationer.

Om du är intresserad att delta i min intervjustudie, eller har funderingar eller frågor får du gärna kontakta mig: **Indhira4ever@gmail.com**

Du kan alltid hoppa av studien om du ångrar dig framöver, då raderas allt material.

Härmed tillfrågas Du om deltagande i studien

Med värme, Indhira Fredlund

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE

Stödpedagoger

Kort presentation av syftet med intervjun (till exempel att förstå personalens erfarenheter kring social isolering, självbestämmande och balansen till risk för missförhållanden).

1. Var jobbar du nu och vilken erfarenhet har du inom LSS?
2. **Betona frivillighet och anonymitet.**
3. **Fråga om samtycke till att spela in eller anteckna.**

Förebyggande -arbetssätt

- Om du erfarenhet av att boende isolerar sig vill du berätta hur ni gick till väga?
- Vad uppfattar du kan ligga bakom att boende regelbundet tackar nej till insatser och socialt isolerar sig?
- Hur bedömer ni om en boende riskerar att bli isolerad?
- Vilka arbetssätt tillämpar ni för att förebygga social isolering som kan leda till missförhållanden? Som exempel återhämtningsinriktat arbetssätt eller personcentrerat förhållningssätt?
- Hur upplever du att dessa arbetssätt fungerar i praktiken?
- Hur dokumenteras bemötandet av den boende i GFP, i hur en boende vill ha bemötandet när denne regelbundet ställer in insatser? Om det inte finns i GFP finns det i form av bemötandeplan?

Arbetssätt/isolering

- Vad ska ni göra om någon socialt isolerar sig från personalen?

Relation

- Hur arbetar ni in er för att få en bra relation till den boende?
- Hur arbetar ni med boende när relationen till den boende och förtroende till personalen inte finns?

Självbestämmande

- Hur pratar du om självbestämmande i arbetsgruppen? Jag har hört att det förekommer att personal anser att en boende är ”Självgående” och det senare visar sig att de ej fått sina behov tillgodosedda och missförhållande uppstått, kan du berätta om dina erfarenheter kring detta?
- Kan du ge exempel på situationer där självbestämmande och risk bedömts olika av personalen och det har lett till risk för missförhållanden eller missförhållanden?
- Vilka verktyg eller metoder används för att bedöma självbestämmande vs risker?

Sektionschef

Kort presentation av syftet med intervjun (till exempel att förstå personalens erfarenheter kring social isolering, självbestämmande och balansen till risk för missförhållanden).

1. Var jobbar du nu och vilken erfarenhet har du inom LSS?
2. Betona frivillighet och anonymitet.
3. Fråga om samtycke till att spela in eller anteckna.

Förebyggande -arbetssätt

- Om du erfarenhet av att boende socialt isolerar sig, vill du berätta hur ni gick till väga?
- Vad uppfattar du kan ligga bakom att boende tackar regelbundet nej till insatser och socialt isolerar sig?
- Brukar ni ta upp dessa frågor på ledningsmöten?
- Hur bedömer ni om en boende riskerar att bli isolerad?
- Vilka arbetssätt tillämpar ni för att förebygga social isolering som kan leda till missförhållanden? Som exempel återhämtningsinriktat arbetssätt eller personcentrerat förhållningssätt?
- Hur upplever du att dessa arbetssätt fungerar i praktiken?
- Hur dokumenteras bemötandet av den boende i genomförandeplanen, i hur en boende vill ha bemötandet när denne regelbundet ställer in insatser? Om det inte finns i genomförandeplanen, finns det i form av bemötandeplan?

Arbetssätt/isolering

- Vad ska ni göra om någon socialt isolerar sig från personalen?

Relation

- Hur arbetar ni in er för att få en bra relation till den boende?
- Hur arbetar ni med boende när relationen till den boende och förtroende till personalen inte finns?

Självbestämmande

- Hur pratar du om självbestämmande i arbetsgruppen? Jag har hört att det förekommer att personal anser att en boende är ”Självgående” och det senare visar sig att de ej fått sina behov tillgodosedda och missförhållande uppstått? Kan du berätta om dina erfarenheter kring detta.
- Kan du ge exempel på situationer där självbestämmande och risk bedömts olika av personalen och det har lett till risk för missförhållanden eller missförhållanden?
- Vilka verktyg eller metoder används för att bedöma självständighet vs risker?